



Organisation
mondiale de la Santé



Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques

2022-2031

Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques

2022-2031

Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022–2031
[Intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders 2022–2031]

ISBN 978-92-4-007987-8 (version électronique)

ISBN 978-92-4-007988-5 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé 2024

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué cidessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022–2031 [Intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders 2022–2031]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://apps.who.int/iris/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Crédits photos: Couverture © Unsplash/Terry Boynton. Page viii © Unsplash/Jixiao Huang. Page 7 © Unsplash/ Eye For Ebony. Page 8 © Unsplash/Nathan Anderson. Page 11 © Unsplash/Joice Kelly. Page 15 © Unsplash/Robert Collins. Page 37 © Unsplash/William Krause.

Table des matières

Avant-propos.....	vii
Contexte.....	1
Vue d'ensemble de la situation mondiale.....	2
Portée.....	5
Vision.....	9
But.....	9
Objectifs stratégiques.....	10
Principes directeurs.....	12

Objectif stratégique 1 : Améliorer la hiérarchisation des politiques et renforcer la gouvernance 16

1.1 Sensibilisation.....	17
1.2 Politique, plans et législation.....	19
1.3 Financement.....	22

Objectif stratégique 2 : Fournir un diagnostic, un traitement et des soins efficaces et adaptés, en temps opportun 24

2.1 Parcours de soins.....	25
2.2 Médicaments, produits de diagnostic et autres produits de santé.....	29
2.3 Renforcement des capacités, formation et soutien au bénéfice des agents de santé.....	32
2.4 Soutien aux aidants.....	35

Objectif stratégique 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention 38

3.1 Promotion des comportements sains tout au long de la vie.....	39
3.2 Lutte contre les maladies infectieuses.....	42
3.3 Prévention des traumatismes crâniens/rachidiens et des handicaps associés.....	44
3.4 Réduction des risques environnementaux.....	46
3.5 Promotion d'un développement optimal du cerveau chez les enfants et les adolescents.....	48

Objectif stratégique 4 : Favoriser la recherche et l'innovation et renforcer les systèmes d'information 52

- 4.1 Investissement dans la recherche.....53
- 4.2 Systèmes de données et d'information.....56

Objectif stratégique 5 : Renforcer l'approche de santé publique à l'égard de l'épilepsie 58

- 5.1 Accès aux services de prise en charge de l'épilepsie.....59
- 5.2 Mobilisation des personnes atteintes d'épilepsie et soutien en leur faveur62
- 5.3 L'épilepsie comme point d'entrée d'autres troubles neurologiques64

Annexe 1 : Résolutions et engagements mondiaux présentant un intérêt
par rapport aux troubles neurologiques.....66

Annexe 2 : Indicateurs pour mesurer les progrès accomplis par rapport aux cibles
définies dans le Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres
troubles neurologiques 2022-2031 70

Avant-propos

Chaque année, les troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie et la démence, tuent neuf millions de personnes, ce qui les place parmi les principales causes de décès et de handicap dans le monde. Les populations marginalisées et celles qui vivent dans des communautés où les systèmes de santé sont médiocres sont particulièrement vulnérables. Le fardeau que représentent les troubles neurologiques est aggravé par la stigmatisation et la discrimination, qui peuvent entraver les possibilités offertes par la vie, augmenter le risque de pauvreté et entraîner des difficultés d'accès aux soins.

En fait, de nombreux troubles neurologiques sont évitables, et beaucoup de progrès sont actuellement réalisés dans les traitements et la recherche. Le Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques, élaboré en 2022 à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, vise à donner des orientations sur la manière de mettre ces avancées au service des systèmes de santé et des communautés, afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de troubles neurologiques.

De nombreuses parties prenantes ont participé à l'élaboration du Plan d'action, y compris des personnes ayant une expérience de ces affections, des gouvernements, des organisations de la société civile, des chercheurs et le secteur privé. Tous ont, par une réflexion approfondie, contribué à définir les changements qui doivent être apportés à la prise en charge des troubles neurologiques.

Le Plan d'action conceptualise plusieurs domaines stratégiques dans lesquels il convient de repenser la situation actuelle. Il s'agit notamment de donner la priorité aux troubles neurologiques au sein des systèmes de santé et de renforcer la gouvernance à cet égard ; de

fournir un diagnostic, un traitement et des soins efficaces et adaptés, en temps opportun ; de mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention ; de favoriser la recherche et l'innovation tout en renforçant les systèmes d'information ; et d'améliorer l'approche de santé publique à l'égard de l'épilepsie. Les dix cibles mondiales permettront de mieux mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Plan d'action.

Le plan est conçu, par sa portée ambitieuse, pour remédier à la négligence dont pâtissent depuis longtemps les troubles neurologiques. Les États Membres, les partenaires nationaux et internationaux et l'OMS doivent travailler ensemble pour concrétiser la vision du Plan d'action, à savoir un monde dans lequel l'importance de la santé du cerveau est reconnue, promue et protégée tout au long de la vie ; les troubles neurologiques sont prévenus, diagnostiqués et traités ; la mortalité et la morbidité prématurées sont évitées ; et les personnes atteintes de troubles neurologiques jouissent de l'égalité des droits, des chances, du respect et de l'autonomie.



Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Directeur général
Organisation mondiale de la Santé



Contexte

1. En novembre 2020, la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA73.10 priant le Directeur général de l'OMS, notamment, d'élaborer un plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques sur 10 ans en concertation avec les États Membres afin de promouvoir et de soutenir une action coordonnée et globale entre plusieurs secteurs.
2. Le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 vise à améliorer l'accès des personnes atteintes de troubles neurologiques aux soins et aux traitements, tout en prévenant l'apparition de nouveaux cas et en favorisant la santé et le développement du cerveau tout au long de la vie. Il s'attache à promouvoir le rétablissement, le bien-être et la participation des personnes atteintes de troubles neurologiques, tout en réduisant la mortalité, la morbidité et le handicap qui leur sont associés, en mettant en avant les droits humains et en luttant contre la stigmatisation et la discrimination au moyen d'approches interdisciplinaires et intersectorielles.
3. Le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 s'appuie sur des résolutions, des décisions, des rapports et des engagements mondiaux antérieurs, dont la résolution WHA68.20 sur la charge mondiale de l'épilepsie et la nécessité d'une action coordonnée au niveau des pays pour influencer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l'opinion publique. Un certain nombre d'approches préventives, pharmacologiques et psychosociales sont communes à l'épilepsie et à d'autres troubles neurologiques. Ce partage de stratégies et d'approches (c'est-à-dire les synergies) peut constituer un point d'entrée précieux pour accélérer et renforcer les services et le soutien en rapport avec l'épilepsie et les autres troubles neurologiques.



Vue d'ensemble de la situation mondiale

4. Les troubles du système nerveux sont la principale cause de perte d'années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) et la deuxième cause de décès dans le monde, avec 9 millions de décès par an. En 2016, l'accident vasculaire cérébral (42,2 %), la migraine (16,3 %), la démence (10,4 %), la méningite (7,9 %) et l'épilepsie (4,9 %) étaient les cinq maladies ayant le plus contribué à la perte de DALY.¹ Dans le monde, en 2016, 52,9 millions d'enfants âgés de moins de cinq ans présentaient des troubles du développement ; 95 % d'entre eux vivaient dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.²

5. La lourde charge de morbidité associée aux troubles neurologiques est aggravée par de profondes inégalités en matière de santé. Ainsi, près de 80 % des 50 millions de personnes atteintes d'épilepsie vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, où les lacunes de la couverture thérapeutique dépassent 75 % dans la plupart des pays à faible revenu et

50 % dans la majorité des pays à revenu intermédiaire.³ Les handicaps associés aux affections neurologiques touchent particulièrement les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant dans la pauvreté et dans des zones rurales ou reculées, ainsi que d'autres populations vulnérables. Les femmes sont également souvent touchées de manière disproportionnée par les troubles neurologiques, tels que la démence, la migraine et la sclérose en plaques. Les enfants issus de ménages défavorisés, de populations autochtones, de minorités ethniques, ainsi que les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les apatrides, les réfugiés et les migrants sont eux aussi beaucoup plus exposés au risque de handicap associé aux affections neurologiques.

6. Les troubles neurologiques engendrent une augmentation des dépenses pour les pouvoirs publics, les communautés, les familles et les individus, ainsi que des

1 Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol.* 2019;18(5):459–480. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30499-X. Voir également Global health estimates 2020: Disease burden by cause, age, sex by country and by region, 2000–2019. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020.

2 Developmental disabilities among children younger than 5 years in 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet.* 2018;6(10):E100–E1121. doi: 10.1016/S2214-109X(18)30309-7.

3 Epilepsy: a public health imperative. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019.

pertes de productivité pour les économies. En 2010, selon les estimations, les troubles neurologiques ont coûté 798 milliards d'euros rien qu'en Europe.⁴ En 2019, à l'échelle mondiale, on estimait le coût sociétal total de la démence à 1300 milliards dollars des États-Unis (USD), soit l'équivalent de 1,5 % du PIB mondial.⁵

7. De nombreuses affections neurologiques sont évitables, y compris 25 % des cas d'épilepsie à l'échelle mondiale.⁶ On sait que de nombreux déterminants, y compris les facteurs environnementaux de risque et de protection, ont une incidence sur le développement du cerveau au début de la vie et sur la santé du cerveau tout au long de la vie. Parmi les facteurs de protection qui ont une incidence sur le développement du cerveau au début de la vie, on trouve l'éducation, les liens sociaux et le soutien social, une alimentation saine, le sommeil et l'activité physique.
8. Partout dans le monde, les personnes atteintes de troubles neurologiques et de handicaps qui y sont liés sont encore victimes de discrimination et de violation des droits humains. C'est la raison pour laquelle le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 tient compte des droits humains énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments

internationaux et régionaux relatifs aux droits humains.

9. Il est particulièrement important de soutenir les éléments constitutifs du système de santé voulus pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurologiques. Il est capital de mettre en œuvre des politiques générales et une législation adaptées, dont l'objectif devrait être de promouvoir la prestation de soins de qualité, de fournir une protection financière et sociale (y compris une couverture contre les dépenses de santé à la charge des patients) et d'assurer le respect et la réalisation des droits des personnes atteintes de troubles neurologiques. Les interventions globales qui visent à lutter contre les troubles neurologiques doivent reposer sur une démarche solide qui tienne compte des déterminants sociaux et économiques de la santé.
10. Les systèmes de santé n'ont pas encore apporté de réponse adéquate au fardeau que représentent les troubles neurologiques. Alors que près de 70 % des personnes atteintes de troubles neurologiques vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire,⁷ les besoins de ces personnes sont insuffisamment pris en compte, 28 % seulement des pays à faible revenu déclarant avoir adopté une politique axée sur ces troubles.² Le nombre d'agents de santé spécialisés en neurologie est actuellement insuffisant pour combler les lacunes en matière de traitement à l'échelle mondiale. Les effectifs médians dans ce domaine

4 J Olesen 1, A Gustavsson, M Svensson, H-U Wittchen, B Jönsson, CDBE2010 study group, et al. The economic cost of brain disorders in Europe. *Eur J Neurol*. 2012; 19(1):155–162. doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03590.x.

5 Global status report on the public health response to dementia. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021.

6 Epilepsy: a public health imperative. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019.

7 Feigin VL, Vos T, Nichols E, Owolabi MO, Carroll WM, Dichgans M, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. *Lancet Neurol*. 2020 Mar;19(3):255–265. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30411-9.

(définis comme le nombre total de neurologues pour adultes, de neurochirurgiens et de neurologues pédiatriques) dans les pays à faible revenu sont de 0,1 pour 100 000 habitants, contre 7,1 pour 100 000 dans les pays à revenu élevé.⁸

- 11.** L'actuelle pandémie de COVID-19 souligne l'intérêt que présente la neurologie pour la santé publique mondiale et son importance dans le cadre des débats plus larges sur la santé mondiale. La perturbation des services, l'inaccessibilité des médicaments, l'interruption des programmes de vaccination et l'augmentation des problèmes de santé mentale alourdissent le fardeau des personnes atteintes de troubles neurologiques. Plus directement, les manifestations neurologiques de l'infection par le virus de la COVID-19 sont présentes à la fois dans la phase aiguë de la maladie et dans l'affection post-COVID-19. Certaines affections neurologiques sous-jacentes représentent un facteur de risque d'hospitalisation et de décès lié à la COVID-19, en particulier chez les personnes âgées.⁹ Le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 offre une occasion sans précédent de s'attaquer aux conséquences des troubles neurologiques par une réponse globale pendant toute la durée de la pandémie et au-delà.

8 ATLAS Country Resources for Neurological Disorders, second edition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017.

9 Neurology and COVID-19, Document d'information scientifique de l'OMS (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Neurology-2021.1>, consulté le 6 avril 2022).

Portée

12. Le terme « troubles neurologiques » est employé pour désigner les atteintes du système nerveux central et périphérique qui englobent l'épilepsie ; les céphalées, dont la migraine ; les maladies neurodégénératives (y compris la démence et la maladie de Parkinson) ; les maladies cérébrovasculaires (y compris l'accident vasculaire cérébral ou AVC) ; les troubles neuro-infectieux ou neuro-immunologiques (y compris la méningite, l'infection à VIH, la neurocysticercose, le neuropaludisme et la sclérose en plaques) ; les troubles neuromusculaires (y compris la neuropathie périphérique, les dystrophies musculaires et la myasthénie grave) ; les troubles neurodéveloppementaux (y compris les troubles du spectre autistique et les troubles neurologiques congénitaux) ; les traumatismes cérébraux et les lésions de la moelle épinière (« moelle spinale », selon la nouvelle nomenclature) et les cancers du système nerveux. Même si certains troubles neurologiques sont rares, ils restent responsables d'une morbidité et d'une mortalité élevées.
13. Conformément à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'OMS, le fonctionnement et le handicap doivent être considérés comme le résultat d'interactions entre un état neurologique et des facteurs liés au contexte tout au long de la vie. Une approche holistique est donc requise pour tenir compte des influences médicales, individuelles, sociales et environnementales.
14. Pour répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles neurologiques, il faut d'abord mieux faire connaître et comprendre ces troubles et s'attaquer à la stigmatisation et à la discrimination, qui ont une incidence sur le bien-être et créent des barrières pour ces personnes lorsqu'il s'agit de se faire soigner. Le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 n'est pas structuré en fonction des maladies, mais repose plutôt sur un cadre intégré et axé sur la personne pour la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins des personnes atteintes de troubles neurologiques. La prévention des troubles neurologiques repose sur la promotion d'une santé du cerveau optimale tout au long de la vie. Une santé du cerveau satisfaisante est un état dans lequel chaque personne peut apprendre, atteindre son plein potentiel et optimiser ses réactions cognitives, psychologiques, neurophysiologiques et comportementales pour s'adapter aux changements de l'environnement.
15. D'autres disciplines ou domaines de la santé publique présentent un lien étroit avec les troubles neurologiques, sur lesquels ils ont une incidence. Il s'agit notamment de la santé mentale, des violences, des traumatismes, des maladies non transmissibles (MNT), des maladies infectieuses et de la santé environnementale. D'autres stratégies ou plans d'action de l'OMS ou résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé s'intéressent à de nombreuses affections neurologiques. En outre, il existe des liens stratégiques entre les troubles neurologiques, d'une

part, et les systèmes de santé et la couverture sanitaire universelle (CSU), d'autre part, y compris l'éventail complet des services de santé essentiels, allant de la promotion de la santé à la prévention, au traitement, à la réadaptation et aux soins palliatifs. Partant du constat qu'il existe des liens bien établis entre la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, la santé reproductive, le vieillissement, la santé du cerveau et les troubles neurologiques, le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 s'inscrit en droite ligne du Programme 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) et porte sur toutes les étapes de la vie.

16. Les liens faits entre le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 et d'autres engagements mondiaux¹⁰ témoignent de la capacité de l'OMS de centrer son action sur la santé des personnes et de travailler de manière cohérente et intégrée.
17. Le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 énonce une vision, un but, des principes directeurs et des objectifs stratégiques, assortis de domaines d'action et de cibles. Il propose aux États Membres, au Secrétariat de l'OMS et aux partenaires internationaux et nationaux une série de mesures à prendre. Bien que les cibles soient définies à l'échelle mondiale, chaque État Membre peut s'en inspirer pour fixer ses propres cibles nationales, en tenant compte de la situation du pays et des difficultés qu'il doit surmonter.¹¹

10 La liste des résolutions et des engagements mondiaux ayant trait aux troubles neurologiques est disponible en anglais à l'adresse <https://www.who.int/news/item/12-01-2022-draft-intersectoral-global-action-plan-on-epilepsy-and-other-neurological-disorders-2022-2031> (consulté le 6 avril 2022).

11 Une synthèse des cibles et indicateurs mondiaux est disponible en anglais à l'adresse <https://www.who.int/news/item/12-01-2022-draft-intersectoral-global-action-plan-on-epilepsy-and-other-neurological-disorders-2022-2031> (consulté le 28 février 2022).





Vision

18. La vision du plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 est celle d'un monde dans lequel :

- l'importance de la santé du cerveau est reconnue, promue et protégée tout au long de la vie ;
- les troubles neurologiques sont prévenus, diagnostiqués et traités, la mortalité et la morbidité prématurées sont évitées ; et
- les personnes atteintes de troubles neurologiques et leurs aidants jouissent du meilleur état de santé possible, sur la base d'une égalité des droits, des chances, du respect et de l'autonomie.

But

19. Le but du plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 est de réduire la stigmatisation, les conséquences et la charge associées aux troubles neurologiques, y compris la mortalité, la morbidité et le handicap, et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurologiques, de leurs aidants et de leur famille.

20. Pour atteindre le but et la vision susmentionnés, il convient de renforcer, autant que possible, la prévention, le traitement et la prise en charge de l'épilepsie et des autres troubles neurologiques, en s'appuyant sur les points d'entrée et les synergies pour parvenir aux meilleurs résultats pour tous.

Objectifs stratégiques

21. Les objectifs stratégiques du plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 sont les suivants :



Améliorer la hiérarchisation des politiques et renforcer la gouvernance



Fournir un diagnostic, un traitement et des soins efficaces et adaptés, en temps opportun



Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention



Favoriser la recherche et l'innovation et renforcer les systèmes d'information



Renforcer la démarche de santé publique à l'égard de l'épilepsie



Principes directeurs

22. Les six principes directeurs du plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 sont les suivants :

a

Soins de santé primaires et CSU centrés sur la personne

Toutes les personnes atteintes de troubles neurologiques et leur famille doivent participer et bénéficier d'un accès équitable, sans discrimination ou sans être exposées à un risque de difficultés financières, à un large éventail de services de promotion de la santé, de prévention, de diagnostic, de traitement, de réadaptation, de soins palliatifs et de services sociaux, ainsi qu'à des médicaments et d'autres produits de santé essentiels, efficaces, sûrs, économiquement abordables et de qualité.

b

Approche intégrée des soins tout au long de la vie

L'intégration des soins pour les troubles neurologiques est indispensable pour que la promotion de la santé, la prévention et la prise en charge donnent de meilleurs résultats. Cela est particulièrement important, plusieurs troubles neurologiques pouvant survenir en même temps, ou en association avec d'autres problèmes de santé qui sont souvent liés à des facteurs de risque communs évitables. La prise en charge des troubles neurologiques nécessite d'être totalement en phase avec d'autres services et programmes existants, conformément au Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la personne,¹ et de tenir compte des besoins en soins de santé et en services sociaux à toutes les étapes de la vie.

¹ Voir le document A69/39 ; voir également Framework on integrated people-centred health services (IPCHS) (<https://www.who.int/teams/integrated-health-services/clinical-services-and-systems/service-organizations-and-integration>, consulté le 25 avril 2022).

c

Politiques et pratique fondées sur des données probantes

Les éléments de preuve scientifiques et les meilleures pratiques permettent d'élaborer des politiques et des interventions de santé publique d'un bon rapport coût/efficacité, durables et abordables pour la prévention et la prise en charge des troubles neurologiques. Il s'agit notamment des connaissances existantes, des données probantes du monde réel fondées sur la pratique, des préférences des personnes atteintes de troubles neurologiques et de l'expérience acquise dans différents contextes culturels, ainsi que de la transposition des nouvelles données factuelles dans des politiques et une pratique qui permettent de trouver des traitements capables de modifier le cours de la maladie ou de la guérir, des interventions efficaces de prévention et des modèles de soins novateurs.

d

Action intersectorielle

Une action coordonnée et globale contre les troubles neurologiques exige de mettre en place des partenariats et une collaboration entre toutes les parties prenantes. La réalisation d'une telle collaboration nécessite une impulsion décisive au niveau gouvernemental, une délimitation claire des rôles et des responsabilités des différentes parties prenantes, des mécanismes de coordination innovants, dont des partenariats public-privé, la participation de tous les secteurs concernés, tels que la santé, les services sociaux, l'éducation, l'environnement, les finances, l'emploi, la justice et le logement, et des partenariats avec les acteurs de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé, ainsi que des associations qui représentent les personnes atteintes de troubles neurologiques.

e

Autonomisation et participation des personnes souffrant de troubles neurologiques et de leurs aidants

Il faut promouvoir et protéger les besoins sociaux, économiques et éducatifs et les libertés des personnes et des familles touchées par des troubles neurologiques, ainsi que leur donner un degré de priorité élevé. Il faut, par des mécanismes de participation et de consultation, donner un réel pouvoir d'action aux personnes atteintes de troubles neurologiques, à leurs aidants, aux organisations qui les représentent et aux populations locales dans la planification des soins et la prestation de services, ainsi que dans l'élaboration de politiques et de lois, l'exécution de programmes, les activités de plaidoyer, la recherche, le suivi et l'évaluation.

f

Genre, équité et droits humains

L'intégration des questions de genre à l'échelle des systèmes dans tous les efforts déployés pour mener une action de santé publique contre les troubles neurologiques est essentielle à l'édification de sociétés équitables, saines et n'excluant personne. Pour respecter les droits des personnes atteintes de troubles neurologiques et réduire la stigmatisation et la discrimination dont elles font l'objet, il est primordial que ces personnes et leurs aidants jouissent d'un accès universel à des interventions et qu'une attention prioritaire soit accordée aux groupes de population les plus vulnérables, dont les migrants, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant dans la pauvreté et celles faisant face à des situations d'urgence. La mise en œuvre du plan d'action mondial intersectoriel 2022-2031 doit s'attaquer explicitement aux disparités propres à chaque contexte national et s'attacher à réduire les inégalités.





Objectif stratégique 1 :

Améliorer la hiérarchisation des politiques et renforcer la gouvernance

23. Une démarche de santé publique élargie, reposant sur les principes de la CSU et sur les droits humains, est nécessaire pour améliorer les soins et la qualité de la vie des personnes atteintes de troubles neurologiques. Pour ce faire, renforcer la gouvernance dans le domaine des troubles neurologiques suppose que des cadres stratégiques soient établis et étayés par des mécanismes efficaces de surveillance, de réglementation et de responsabilisation.
24. Il convient de remédier au manque de connaissances et de sensibilisation à tous les niveaux de la société, notamment parmi les représentants des pouvoirs publics, les personnes atteintes de troubles neurologiques et les autres parties prenantes, afin de modifier les principaux obstacles structurels et comportementaux à l'obtention de résultats positifs en matière de santé du cerveau, de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, de promouvoir les droits humains des personnes atteintes de troubles neurologiques et d'améliorer les soins dont elles bénéficient et leur qualité de vie.
25. Par une sensibilisation efficace, on peut peser sur l'engagement politique et mobiliser des ressources pour contribuer à rendre prioritaires les politiques sur les troubles neurologiques, notamment en faisant le lien avec la réalisation d'engagements internationaux plus larges tels que ceux définis dans le Programme 2030 et les ODD, ainsi que dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
26. Pour répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles neurologiques dans leurs multiples aspects, il importe d'intégrer et de prendre en considération les troubles neurologiques dans les politiques nationales, la législation et les lignes directrices pertinentes, fondées sur des données probantes et portant sur le secteur de la santé et d'autres secteurs tels que l'éducation, la protection sociale et l'emploi.



Cibles mondiales pour l'objectif stratégique 1

Cible mondiale 1.1

D'ici 2031, **75 % des pays** auront adapté ou mis à jour les politiques, stratégies, plans ou cadres nationaux existants pour y inclure les troubles neurologiques.

Cible mondiale 1.2

D'ici 2031, **100 % des pays** auront au moins une campagne ou un programme opérationnel de sensibilisation aux troubles neurologiques.

27. Le financement de la santé est une fonction essentielle des systèmes de santé qui peut permettre de progresser vers la réalisation de la CSU. Il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre des politiques visant à assurer des dispositifs efficaces de gouvernance des systèmes de santé et de prestation de services, y compris par la collecte de recettes, la mise en commun des fonds et l'achat de services (tels que l'allocation de ressources aux prestataires de services de santé) pour permettre l'accès en temps voulu à des services, une aide et des traitements abordables, résilients et de qualité pour les troubles neurologiques.

1.1 Sensibilisation

28. La sensibilisation représente la première étape pour ce qui est de mieux faire connaître et comprendre au grand public les questions relatives à la santé du cerveau et aux troubles neurologiques. Il est nécessaire d'améliorer la prestation des soins de neurologie, de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, de prévenir la violation des droits humains et de promouvoir ces derniers. La sensibilisation consiste également à faire prendre conscience à l'opinion publique et aux responsables politiques de la charge et des conséquences des troubles neurologiques et à diffuser les données sur les interventions fondées sur des données probantes, y compris pour

promouvoir la santé du cerveau et prévenir et traiter les troubles neurologiques.

29. Pour être efficaces, les actions de plaidoyer, dont les campagnes de sensibilisation du public, doivent être adaptées au contexte socioculturel de chaque pays. En outre, il est impératif de placer les personnes atteintes de troubles neurologiques au centre de tous les efforts de sensibilisation si l'on veut obtenir les résultats sanitaires et sociaux souhaités. Les campagnes de sensibilisation du public devraient inclure des informations sur la promotion et la prévention des troubles neurologiques et devraient être conçues pour les personnes vivant avec des troubles neurologiques.



30. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

- (a) Associer toutes les parties concernées, comme les experts en sensibilisation, les professionnels de la santé et les personnes atteintes de troubles neurologiques et leurs aidants, à l'élaboration de programmes de sensibilisation pour améliorer la compréhension des troubles neurologiques, promouvoir la santé du cerveau et prévenir et prendre en charge les troubles neurologiques tout au long de la vie, y compris pour identifier les obstacles au recours aux soins.
- (b) Établir des mécanismes de collaboration, d'application et de transfert du savoir à l'échelle nationale et régionale pour faire prendre conscience de la charge de morbidité que représentent les troubles neurologiques et de l'existence et de l'accessibilité de services de promotion de la santé, de prévention, de prise en charge et de soins appropriés et reposant sur des bases factuelles pour les personnes atteintes de troubles neurologiques.
- (c) Diriger et coordonner des stratégies de sensibilisation intersectorielles visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont les personnes atteintes de troubles neurologiques font l'objet, y compris les groupes vulnérables, et à promouvoir leurs droits humains tout au long de leur vie. Les intégrer dans des stratégies plus larges de promotion de la santé, comme des modalités d'enseignement et de travail aménagées pour les personnes atteintes de troubles neurologiques.

31. Mesures à prendre par le Secrétariat

- (a) Associer les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et leur famille à la prise de décisions dans les processus internes de l'OMS sur les questions qui les concernent grâce à des mécanismes opérants et structurés.
- (b) Apporter un soutien technique et des outils de sensibilisation à la lutte contre la stigmatisation afin d'aider les responsables de l'élaboration des politiques aux niveaux national, régional et mondial à prendre acte de la nécessité de rendre les troubles neurologiques prioritaires et de les intégrer dans les politiques et les plans.
- (c) Fournir appui et conseils aux États Membres pour associer concrètement les personnes atteintes de troubles neurologiques dans toutes les tranches d'âge en proposant un espace de dialogue, en produisant et exploitant des informations fondées sur des données factuelles et les meilleures pratiques, et en s'appuyant sur l'expérience vécue dans les processus décisionnels.

32. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) En partenariat avec d'autres parties prenantes, plaider pour accroître la visibilité des troubles neurologiques dans les ODD et d'autres engagements mondiaux, et pour donner la priorité aux troubles neurologiques dans les programmes politiques en sensibilisant aux conséquences sociales et économiques des troubles neurologiques et à la nécessité d'organiser une riposte intégrée tout au long de la vie et au sein des systèmes de soins.

(b) Soutenir les initiatives de sensibilisation afin de protéger les droits humains des personnes atteintes de troubles neurologiques, à corriger les inégalités dans l'accès aux services neurologiques pour les populations vulnérables et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Veiller à ce que les personnes atteintes de troubles neurologiques prennent pleinement part aux activités de la collectivité afin de favoriser leur participation à la vie culturelle, sociale et civique et accroître leur autonomie.

(c) Offrir un espace de dialogue entre les associations et les organisations de personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants, les agents de santé et les travailleurs sociaux, les pouvoirs publics et d'autres acteurs concernés aux niveaux international, régional et national, en veillant à ce que des jeunes et des personnes âgées participent et à ce qu'il y ait une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Collaborer avec différents secteurs tels que les transports, l'éducation, la justice, la finance et l'emploi à des activités de plaidoyer visant à accroître l'indépendance et l'autonomie des personnes atteintes de troubles neurologiques.

1.2 Politique, plans et législation

33. L'élaboration de politiques, de textes de loi et de plans globaux et intersectoriels sur la base d'éléments de preuve scientifiques et conformes aux normes internationales en matière de droits humains renforce la gouvernance dans le domaine des troubles neurologiques et permet que les besoins complexes des personnes atteintes de ces troubles soient mieux satisfaits, suivant le contexte de chaque pays.

34. La collaboration entre les personnes atteintes de troubles neurologiques, les experts techniques qui rassemblent les données factuelles, les responsables de l'élaboration des politiques et les directeurs de programme qui formulent, adaptent et appliquent les politiques, les plans, les lignes directrices et la législation, ainsi que les professionnels de la santé qui fournissent des soins et des services aux personnes atteintes de troubles neurologiques est indispensable pour faciliter et mettre en œuvre des politiques et des plans qui reposent sur des données probantes dans tous les secteurs.



35. Étant donné les liens qui unissent les troubles neurologiques et d'autres domaines de la santé publique, il existe de nombreuses possibilités d'intégrer ces troubles dans les politiques et les plans élaborés dans ces domaines, par exemple, les maladies non transmissibles et transmissibles, la santé mentale, la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, le vieillissement et le handicap.

36. Les textes de loi qui influent sur la vie des personnes atteintes de troubles neurologiques (par exemple d'épilepsie) sont souvent dépassés et ne permettent pas de protéger et de promouvoir leurs droits humains. Il est capital de mettre à jour toutes les lois qui concernent les personnes atteintes de troubles neurologiques, par exemple celles liées à l'éducation, à l'emploi et aux droits des femmes, et de veiller à ce qu'elles soient plus inclusives.

37. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) À l'échelon national et/ou infranational, élaborer et mettre en œuvre des politiques, des plans et une législation qui luttent contre les troubles neurologiques, en tant qu'instruments indépendants ou en les intégrant à d'autres plans intersectoriels dans les domaines des MNT, de la santé mentale, du handicap et d'autres domaines pertinents, tout au long de la chaîne de soins et concernant tous les âges, ou examiner, actualiser et renforcer les politiques, les plans et la législation qui existent en la matière. Formuler et mettre en œuvre des politiques et des lois nationales en consultation avec les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et d'autres parties prenantes afin de promouvoir et de protéger leurs droits et de prévenir la stigmatisation et la discrimination.

(b) Établir des mécanismes de suivi et de responsabilisation pour l'allocation des ressources, y compris au moyen de points focaux, d'unités ou de divisions fonctionnelles responsables des troubles neurologiques au sein du ministère de la santé (ou de son équivalent).

(c) Revoir les politiques et les lois sur le handicap et sur d'autres domaines pertinents afin qu'elles incluent davantage les personnes atteintes de troubles neurologiques, y compris en modifiant les critères d'accès aux prestations d'invalidité ; en fournissant des fonds pour soutenir les personnes handicapées qui exercent un emploi ; en mettant en place un système de quotas favorisant l'embauche active ; en rendant les environnements de travail plus accessibles grâce à la réglementation sur l'emploi et au droit du travail qui régissent les secteurs public et privé, et en renforçant les mécanismes qui traitent les réclamations et les plaintes liées aux violations des droits humains et à la discrimination à l'égard des personnes atteintes de troubles neurologiques au moyen de processus de recours impartiaux.

38. Mesures à prendre par le Secrétariat

: fournir un appui, des outils et des orientations techniques aux États Membres et aux responsables de l'élaboration des politiques pour qu'ils :

- (a) mettent en commun les connaissances et les meilleures pratiques reposant sur des bases factuelles afin d'éclairer l'élaboration, le renforcement, la mise en œuvre et l'évaluation de politiques, lois et plans nationaux et/ou infranationaux qui sont conformes aux normes internationales en matière de droits humains en vue d'une action intersectorielle intégrée contre les troubles neurologiques ;
- (b) renforcent les mécanismes de responsabilisation et les stratégies destinées à régler les plaintes et réclamations afin de remédier aux violations des droits humains et à la discrimination qui visent les personnes atteintes de troubles neurologiques, par exemple dans les domaines de l'emploi, de l'accès à l'éducation, de la conduite automobile, de la procréation et des droits des femmes ;
- (c) adoptent une législation qui garantisse un accès universel aux prestations financières, sociales et d'invalidité pour les personnes atteintes de troubles neurologiques et leurs aidants ;
- (d) apportent une assistance dans la définition de mécanismes qui encouragent et appuient de manière proactive la participation active des personnes atteintes de troubles neurologiques dans tous les aspects de l'élaboration des politiques, de la planification et du financement des services ; et
- (e) fournissent en permanence aux États Membres un suivi, des orientations et un soutien technique afin qu'ils mettent en œuvre le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031, avec l'aide des bureaux régionaux et de pays de l'OMS à tous les niveaux.

39. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

- (a) Faire participer activement les parties prenantes de tous les secteurs pour guider l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de plans et de textes de loi reposant sur des bases factuelles en portant une attention particulière aux droits humains des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants, et pour prévenir la stigmatisation et la discrimination.
- (b) Contribuer à la création d'associations et d'organisations regroupant des personnes atteintes de troubles neurologiques, leur famille et leurs aidants ou renforcer celles qui existent déjà, et favoriser leur collaboration avec d'autres organisations en tant que partenaires dans la prévention et le traitement des troubles neurologiques.
- (c) Faciliter le partage de connaissances et le dialogue entre les associations représentant les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et leur famille et leurs organisations,



39. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre (suite)

ainsi que les agents de santé, les travailleurs sociaux et l'État pour faire en sorte que les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, tels que l'autonomisation, la participation et l'inclusion, soient intégrés dans la législation afin de promouvoir la santé des personnes atteintes de handicaps secondaires à des troubles neurologiques.

1.3 Financement

40. Les troubles neurologiques engendrent une augmentation des dépenses pour les pouvoirs publics, les communautés, les familles et les individus, ainsi qu'une perte de productivité pour les économies, des coûts qui pourraient en grande partie être évités grâce à la prévention, une détection précoce et un traitement rapide. Les personnes atteintes de troubles neurologiques et leur famille font face à d'importantes difficultés financières en raison des coûts des soins de santé et des services sociaux ainsi que de la diminution ou de la perte de revenus. Cette situation est aggravée par l'absence d'assurance maladie universelle dans tous les pays, où les investissements et les ressources consacrés aux affections neurologiques sont faibles.

41. Il est nécessaire que les politiques et programmes soient assortis d'un financement adéquat afin de garantir l'accès des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants à la prévention, au diagnostic, au traitement et aux soins et de réduire l'incidence financière des dépenses à leur charge en matière de santé et de protection sociale. Ces investissements seront compensés par une réduction du coût de l'invalidité neurologique et réduiront en fin de compte les coûts à long terme pour les pouvoirs publics.

42. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Garantir un financement pérenne des politiques, plans et programmes de prévention et de prise en charge des troubles neurologiques, reposant sur une action intégrée tout au long de la vie, au moyen de crédits budgétaires nationaux réservés, d'une utilisation efficiente et rationnelle des ressources, de mécanismes novateurs et volontaires de financement et d'autres moyens, comme le financement multilatéral, bilatéral et commun et les partenariats public-privé.

(b) Produire et/ou utiliser les données les plus récentes sur la charge épidémiologique et économique des troubles neurologiques, ainsi que sur la logique économique des investissements et les coûts prévus de la mise à l'échelle des interventions, afin de prendre des décisions éclairées sur les budgets et que ceux-ci soient proportionnels à l'ampleur du fardeau supporté par le pays et d'allouer les faibles ressources de façon optimale.

42. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

(c) Élaborer des mécanismes de protection financière et sociale, notamment des régimes d'assurance maladie et des prestations de sécurité sociale nationaux, pour prendre en charge les coûts directs et indirects qu'occasionne l'accès aux soins (frais de transport, par exemple) et pour garantir des soins abordables et accessibles aux personnes atteintes d'affections neurologiques, à leurs aidants et à leur famille.

43. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Promouvoir la collaboration et le partage de connaissances aux échelons international, régional et national pour consolider le savoir sur les incidences socioéconomiques des investissements dans le domaine des troubles neurologiques.

(b) Fournir un appui technique, des outils et des orientations aux États Membres pour qu'ils renforcent leur capacité de procéder à la planification intersectorielle des ressources, à la budgétisation et au suivi des dépenses en matière de troubles neurologiques.

(c) Fournir des orientations pour des approches structurées visant à générer des investissements nationaux en faveur des troubles neurologiques et de la promotion, des soins et de la protection de la santé du cerveau, en accord avec d'autres méthodes d'analyse des argumentaires d'investissement existantes pour soutenir les choix des gouvernements.

44. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Apporter un soutien aux États Membres pour mobiliser des ressources financières pérennes et recenser les lacunes fonctionnelles dans l'allocation des ressources afin d'appuyer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et services nationaux et/ou infranationaux axés sur les troubles neurologiques.

(b) Soutenir la participation des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants aux processus décisionnels liés aux mécanismes de financement internationaux.

(c) Contribuer à l'élaboration de modèles de financement novateurs, comme un fonds d'aide internationale, afin de subventionner et de financer les coûts des produits de diagnostic et des traitements, et de compenser les coûts associés à l'orientation des patients (comme les frais de déplacement et les services et interventions de spécialistes).

(d) Soutenir la responsabilisation et l'efficacité de l'utilisation des ressources dans les systèmes de soins de santé afin d'allouer les maigres ressources de manière optimale et d'améliorer la qualité et l'efficacité en limitant le plus possible le gaspillage des ressources.



Objectif stratégique 2 :

Fournir un diagnostic, un traitement et des soins efficaces et adaptés, en temps opportun

45. Les troubles neurologiques sont une cause importante de mortalité, de morbidité et de handicap. Ils exigent de déployer des efforts intersectoriels concertés afin de répondre aux besoins des personnes qui risquent de les développer ou qui en sont atteintes, en leur fournissant un accès équitable à des soins de santé efficaces et à des interventions et services sociaux, éducatifs et professionnels au niveau local.

46. L'intégration de la prise en charge des troubles neurologiques dans les soins de santé primaires, secondaires et tertiaires ainsi que la fourniture de médicaments et de produits de diagnostic essentiels et la formation et l'accompagnement des agents de santé, des aidants et familles des personnes atteintes de ces troubles sont

autant de mesures conformes aux principes de la couverture sanitaire universelle ainsi qu'au Programme de développement durable à l'horizon 2030 et aux ODD.

47. Pour améliorer la qualité de la vie et le bien-être des personnes atteintes de troubles neurologiques, mais aussi pour éviter les complications, réduire les hospitalisations et les interventions onéreuses et prévenir les décès prématurés et le handicap, il faut un système de santé solide qui adopte une démarche centrée sur la personne et une stratégie de coordination des soins, et qui soit axé sur un diagnostic, un traitement et une prise en charge efficaces, adaptés, et fournis en temps opportun, sur de longues périodes.



Cibles mondiales pour l'objectif stratégique 2

Cible mondiale 2.1

D'ici à 2031, **75 % des pays** auront intégré les troubles neurologiques dans les prestations de la CSU.

Cible mondiale 2.2

D'ici à 2031, **80 % des pays** fourniront, dans le cadre des soins primaires, les médicaments essentiels et les technologies de base nécessaires à la prise en charge des troubles neurologiques.

2.1 Parcours de soins

- 48.** Pour mettre en place des soins interdisciplinaires pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, il faut des lignes directrices fondées sur des protocoles et des pratiques qui reposent elles-mêmes sur des données probantes, une organisation par étapes de soins et une approche fondée sur le parcours de vie.
- 49.** Les services et parcours de soins, notamment l'accès à des soins d'urgence de qualité, doivent permettre de répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles neurologiques, de leurs aidants et de leur famille, qu'ils vivent dans des zones urbaines ou rurales, et être ouverts aux groupes de populations vulnérables, y compris les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique, les enfants, les personnes âgées, les personnes exposées à la violence domestique et fondée sur le genre, les détenus, les réfugiés, les populations déplacées et les migrants, les populations autochtones et d'autres groupes, en fonction du contexte national.
- 50.** Un parcours de soins doit englober toutes les étapes du parcours de vie, depuis la grossesse et la petite enfance jusqu'au grand âge. Il englobe les soins de suite prodigués aux enfants et aux adolescents atteints de troubles neurologiques, notamment pour aider ces derniers à opérer la transition vers l'âge adulte.
- 51.** Les affections neurologiques ont des répercussions sur les capacités fonctionnelles des personnes et réduisent souvent leur mobilité, leurs capacités de communication, leurs fonctions cognitives et leurs capacités d'autoprise en charge, nécessitant alors une réadaptation. Cependant, les besoins en réadaptation des personnes atteintes de troubles neurologiques restent largement insatisfaits : seuls 16 % des pays déclarent disposer de services de réadaptation neurologique spécialisés et 17 % indiquent disposer d'unités de réadaptation générale offrant de tels services.¹

¹ ATLAS Country Resources for Neurological Disorders, second edition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017.



52. En raison des niveaux élevés de dépendance et de morbidité des personnes atteintes de troubles neurologiques, et sachant la complexité de leurs besoins, il est essentiel de disposer de toute une gamme de soins de santé et de services sociaux coordonnés, y compris de soins palliatifs pour soulager la douleur ; d'un soutien psychosocial et spirituel et d'une aide à la planification des soins ; et d'interventions visant à améliorer la qualité de vie.

53. Dans la mesure du possible, les parcours de soins doivent inclure l'accès à des installations neurochirurgicales où réaliser des actes chirurgicaux requis dans le traitement des affections neurologiques telles que les tumeurs, l'épilepsie et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus.

54. La continuité des soins peut être optimisée à l'aide de solutions de santé numériques qui favorisent un plus grand partage d'informations entre les prestataires de soins, les personnes atteintes de troubles neurologiques et les aidants et permettent des consultations à distance (télésanté).

55. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Élaborer, pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, des parcours de soins et d'aide sociale coordonnés reposant sur des bases factuelles, dans le cadre de la CSU, afin de leur donner accès à des soins de qualité quand et où elles en ont besoin, tout au long de la vie. Cela suppose une intégration à plusieurs niveaux des systèmes de santé et d'aide sociale, par exemple en recourant à des équipes de soins interdisciplinaires, des annuaires des services et un système de dossiers médicaux, et des mécanismes d'orientation. Il faut en particulier :

- améliorer l'accès équitable à des soins de qualité pour les affections neurologiques aiguës (cas urgents) et chroniques ;
- renforcer les soins aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, y compris les installations médicales et chirurgicales ;
- développer des services neurologiques communautaires avec la participation d'autres prestataires de soins, comme les guérisseurs traditionnels, et promouvoir l'autoprise en charge ; et
- promouvoir la continuité des soins entre les prestataires et les niveaux du système de santé, y compris par l'orientation et le suivi, en veillant à ce que les services de soins de santé primaires soient étayés par des services spécialisés dans les hôpitaux et les services de santé communautaires, dotés eux-mêmes de mécanismes efficaces d'orientation et de réorientation.

55. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

(b) Élaborer des stratégies pour rationaliser l'allocation des ressources et rendre plus efficace la collaboration entre les acteurs des secteurs public, privé et non gouvernemental, notamment par :

- la mise en œuvre de modèles de soins adaptés au contexte, novateurs et intégrés, du diagnostic à la fin de vie, dans les secteurs sanitaire et social ;
- la promotion, la mise en œuvre et l'élargissement de solutions et technologies de santé numérique dans les systèmes de soins et d'aide sociale ; et
- la constitution d'équipes et de réseaux de soins de santé et d'aide sociale interdisciplinaires et le renforcement des capacités des professionnels de la santé et de l'aide sociale.

(c) Faire le point sur les services connexes existants, comme ceux pour la santé mentale, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent et la vaccination, et d'autres programmes pertinents de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, afin de trouver des possibilités d'intégration de la prévention, du diagnostic précoce et de la prise en charge des troubles neurologiques et des comorbidités non neurologiques.

(d) Promouvoir un accès équitable aux services de réadaptation en cas de handicap associé à une affection neurologique en renforçant les systèmes de santé à tous les niveaux, des structures hospitalières spécialisées à la réadaptation communautaire.

(e) Mettre au point de nouveaux services, conseils et protocoles et/ou renforcer ceux existants pour appuyer, en amont, la mise en œuvre de mécanismes d'orientation et de coordination des soins palliatifs et pour garantir aux personnes atteintes de troubles neurologiques un accès équitable aux soins palliatifs.

(f) S'attacher activement à recenser et à fournir des soins et un soutien adaptés aux groupes de population particulièrement exposés au risque de troubles neurologiques ou ayant un accès limité à ces services, tels que les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique, les personnes âgées et d'autres groupes spécifiques, en fonction du contexte national ; et promouvoir l'intégration et la continuité des soins assurés par les prestataires spécialisés dans la prise en charge des adultes et des enfants, afin de faciliter le passage à l'âge adulte pour les adolescents atteints de troubles neurologiques.



55. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre
(suite)

(g) En partenariat avec les intervenants humanitaires, intégrer les besoins de soutien dans les plans de préparation aux urgences de sorte que les personnes atteintes de troubles neurologiques préexistants ou dus à une situation d'urgence, par exemple à la suite de lésions traumatiques, aient accès à des services d'aide suffisamment sûrs.

(h) Donner aux personnes atteintes de troubles neurologiques et à leurs aidants les moyens de participer à la planification et à la prestation des services et leur permettre de faire des choix avisés et de prendre des décisions éclairées qui répondent à leurs besoins en mettant à leur disposition des informations accessibles et fondées sur des données probantes, notamment sur les parcours de soins depuis la détection et le diagnostic jusqu'au traitement (y compris l'autoprise en charge) et à l'accès aux soins.

56. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Fournir aux États Membres des orientations et un soutien technique afin qu'ils identifient les domaines prioritaires pour d'éventuelles interventions et qu'ils intègrent des interventions présentant un bon rapport coût/efficacité contre les troubles neurologiques, leurs facteurs de risque et leurs comorbidités dans leur système de santé et les ensembles de prestations de la CSU.

(b) Apporter un appui technique aux États Membres dans le recueil et la mise en commun des meilleures pratiques de prestation de soins reposant sur des données probantes tout au long de la vie, dont la prestation de services et la coordination des soins interdisciplinaires, en mettant l'accent sur la prévention, le diagnostic, le traitement (y compris la prise en charge des comorbidités), la réadaptation et les soins palliatifs pour les personnes atteintes de troubles neurologiques.

(c) Fournir une assistance technique et des orientations stratégiques pour soutenir la préparation aux situations d'urgence et faire en sorte que les personnes atteintes de troubles neurologiques aient accès à des services suffisamment sûrs.

57. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Associer activement toutes les parties intéressées, tous secteurs confondus – y compris les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et les membres de leur famille – à l'élaboration et à la prestation de soins intersectoriels et interdisciplinaires coordonnés et de parcours de soins neurologiques intégrés assurant la continuité des soins, dont la prévention, le diagnostic, le traitement, la réadaptation et les soins palliatifs.

57. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre (suite)

(b) Faciliter le partage de connaissances et le dialogue pour examiner et améliorer les efforts de renforcement des services de santé à l'échelon local à la suite de situations d'urgence humanitaire, en collaboration avec les institutions multilatérales et régionales compétentes, les organisations représentant les personnes atteintes de troubles neurologiques et d'autres organisations de la société civile.

(c) Produire des données factuelles et mettre au point des outils pour soutenir les programmes d'accès aux soins intégrés pour les personnes atteintes de troubles neurologiques.

(d) Faciliter les initiatives menées en partenariat avec les parties intéressées pour soutenir les personnes atteintes de troubles neurologiques, leur famille et leurs aidants et les encourager à accéder aux soins et services de neurologie, au moyen d'outils technologiques de formation et d'information qui soient adaptés aux usagers et reposent sur des données factuelles, tels que le programme iSupport,² et/ou en mettant en place des services d'assistance et des sites Web nationaux proposant des informations accessibles.

2.2 Médicaments, produits de diagnostic et autres produits de santé

58. Les médicaments, les produits de diagnostic et les autres produits de santé, tels que les technologies d'assistance, les produits biologiques et la thérapie cellulaire et génique, sont essentiels à la prévention, au diagnostic et au traitement pour réduire la mortalité et la morbidité chez les personnes atteintes de troubles neurologiques et améliorer leur qualité de vie.

59. Les médicaments essentiels jouent un rôle central dans la prévention et le traitement des troubles neurologiques. Par exemple, s'il existe des médicaments contre la sclérose en plaques capables de ralentir l'évolution de la maladie et d'améliorer la qualité de la vie de nombreuses personnes, leur

disponibilité et leur accessibilité économique restent limitées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

60. L'utilisation de dispositifs médicaux, notamment des techniques d'imagerie et de diagnostic in vitro (par exemple, la neuro-imagerie, les ponctions lombaires et la microscopie) peuvent réduire la morbidité grâce à une détection précoce et en ralentissant la progression de la maladie. Même lorsque des outils de diagnostic efficaces sont disponibles, ils ne sont pas toujours économiquement abordables ni accessibles, en raison du manque d'infrastructures, de matériel et de personnel qualifié.

² iSupport for dementia. Training and support manual for carers of people with dementia. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019.



61. Les technologies d'assistance permettent aux gens de mener une vie saine, productive, indépendante et digne et réduisent le recours aux services structurés de santé et d'accompagnement des patients, aux soins de longue durée et aux aidants. Malgré les besoins, peu de personnes ont accès à ces produits en raison de leur coût important, de connaissances insuffisantes à leur sujet, d'une offre limitée, du manque de personnel qualifié et de l'insuffisance des politiques et du financement. Pour améliorer l'accès aux produits d'assistance pour ceux qui en ont le plus besoin, ces aides devraient être

disponibles à tous les niveaux des services de santé, en particulier à l'échelon des soins primaires, et être intégrées à la CSU.

62. La production rapide de nouveaux médicaments et molécules que l'on observe pour certains troubles neurologiques est un modèle à suivre pour d'autres affections neurologiques ou troubles de santé. Les obstacles actuels à l'accès au traitement et à l'accessibilité économique devraient être recensés en vue de les lever et d'ouvrir ainsi la voie à des médicaments plus abordables et disponibles.

63. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Promouvoir l'inclusion, la mise à jour et la disponibilité de médicaments et de produits de santé essentiels, efficaces, sûrs, abordables et de qualité contre les troubles neurologiques dans les listes nationales de médicaments essentiels, conformément à la Liste modèle OMS des médicaments essentiels, à la Liste OMS des dispositifs médicaux prioritaires pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires et du diabète, à la Liste OMS des dispositifs médicaux prioritaires pour la prise en charge du cancer et à la Liste OMS des produits d'assistance prioritaires, tout en intégrant l'accès aux médicaments placés sous contrôle et en réduisant au minimum le risque d'usage inadéquat ; recenser les principaux obstacles à l'accès dans les différents groupes de population (y compris dans les situations d'urgence) et les stratégies pour s'y attaquer de façon systématique.

(b) Promouvoir un usage adéquat, transparent et durable des médicaments essentiels pour la prévention et la prise en charge des troubles neurologiques, par des mesures telles que l'assurance de la qualité, les procédures d'homologation préférentielles, la substitution par des produits génériques et des biosimilaires, l'utilisation des dénominations communes internationales et des mesures d'incitation financière, le cas échéant. Optimiser la formation des professionnels de santé, des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants, y compris en mobilisant des stratégies à bases factuelles pour traiter les comorbidités et intervenir face aux événements indésirables et aux interactions médicamenteuses imputables notamment à la polymédication.

(c) En s'appuyant sur la Liste modèle OMS des dispositifs de diagnostic *in vitro* essentiels, favoriser la disponibilité, l'accès et l'utilisation des produits de diagnostic applicables tels que les dispositifs de microscopie, d'électrophysiologie et d'analyse

63. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

génétique ou les technologies de neuro-imagerie comme la tomographie assistée par ordinateur et l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Améliorer les infrastructures et former les techniciens et les agents de santé à l'utilisation de ces technologies.

(d) Établir des cadres réglementaires transparents et prévoir des ressources et des capacités suffisantes pour garantir que les normes de qualité, d'innocuité et d'éthique sont respectées pour les produits de santé et les produits de diagnostic tels que les biothérapies, les tests génétiques, les tests génétiques préimplantatoires et les produits d'assistance comme les aides auditives, les fauteuils roulants et les prothèses.

(e) Améliorer la disponibilité des médicaments et produits de santé essentiels pouvant sauver des vies afin de pouvoir prendre en charge les troubles neurologiques dans les situations d'urgence humanitaire.

64. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Agir plus rapidement et apporter un soutien technique aux États Membres afin de renforcer l'accès équitable aux médicaments, aux produits de diagnostic et aux autres produits de santé, au bénéfice des personnes atteintes de troubles neurologiques, en particulier en établissant des normes et des critères à vocation mondiale et au moyen de réglementations fondées sur des données probantes et adaptées au contexte ; de bonnes pratiques d'achat et de fabrication fondées sur des normes ; et de formations aux aspects techniques, législatives et réglementaires.

(b) Mettre à jour la Liste modèle OMS des médicaments essentiels, la Liste modèle OMS des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels, les Listes OMS de dispositifs médicaux prioritaires, la Liste OMS des produits d'assistance prioritaires et d'autres documents pertinents afin de s'assurer qu'ils sont adaptés aux affections neurologiques et que des moyens existent pour la mise en place et l'utilisation en temps opportun de traitements et de produits de diagnostic efficaces.

65. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Encourager toutes les parties intéressées à mener des activités pour promouvoir les efforts visant à améliorer l'accès à des médicaments, produits de diagnostic et autres produits de santé – tels que les produits de neuro-imagerie – abordables, sûrs, efficaces et de qualité.

(b) Apporter un soutien au renforcement mondial, régional, intergouvernemental, national et/ou local des processus de réglementation et d'achat (y compris par des groupements d'achats, des mécanismes de financement de la santé innovants et



65. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre (suite)

le renforcement des moyens humains) afin de promouvoir l'accès aux médicaments, produits de diagnostic et autres produits de santé et leur usage approprié.

(c) Encourager la participation des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants aux processus de recherche-développement et de mise en œuvre pour les nouveaux médicaments, produits de diagnostic et autres produits de santé.

2.3 Renforcement des capacités, formation et soutien au bénéfice des agents de santé

66. Pour améliorer les résultats sanitaires, il est crucial d'associer plusieurs catégories de personnels : les professionnels requis en matière de neurologie (avec, notamment, des médecins spécialistes en neurologie de l'adulte ou de l'enfant et des neurochirurgiens) ; d'autres prestataires de soins, y compris, mais sans s'y limiter, des psychologues, des psychiatres, des radiologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des orthophonistes ; et, au niveau des soins de santé primaires, des agents de santé compétents correctement formés à l'identification et à la prise en charge des troubles neurologiques.

67. La formation théorique et pratique de ressources humaines issues de plusieurs disciplines, incluant notamment des travailleurs sociaux, des spécialistes de la réadaptation formés aux affections neurologiques, des techniciens (spécialisés en électrophysiologie, en imagerie ou en techniques de laboratoire), des pharmaciens, des ingénieurs biomédicaux, des agents de santé communautaires, des aidants (notamment familiaux) et des guérisseurs, le cas échéant, est nécessaire pour pouvoir prodiguer des soins centrés sur la personne à celles et ceux qui sont atteints de troubles neurologiques, réduire la mortalité et la morbidité et améliorer la qualité de la vie.

68. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Réunir et appliquer des données factuelles adaptées au contexte pour :

- établir des programmes et des politiques dotés de ressources suffisantes pour répondre aux besoins futurs prévus en personnels de santé compte tenu des changements démographiques, du vieillissement de la population et de la prévalence de maladies telles que la démence, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie de Parkinson ; et
- instituer une rémunération et des incitations adéquates pour les agents de santé et les travailleurs sociaux formés aux troubles neurologiques afin de les inciter à travailler dans les régions mal desservies et à s'y installer durablement.

68. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

(b) Renforcer les capacités du personnel de santé et de l'aide sociale à identifier et à prendre en charge rapidement les troubles neurologiques, y compris les comorbidités fréquentes et pouvant être traitées, telles que les maladies infectieuses, les lésions cérébrales hypoxo-ischémiques périnatales, l'hypothyroïdie, la cataracte et les maladies non transmissibles. Ces initiatives devraient mettre l'accent sur le renforcement des ressources humaines existantes, spécialistes comme généralistes et auxiliaires médicaux compris, selon ce qu'exigent leurs fonctions. Elles devraient notamment consister :

- à mettre en œuvre des programmes de formation sous différentes formes (par exemple, la formation en ligne du Programme d'action Comblant les lacunes en santé mentale (mhGAP)) destinés aux agents de santé généraux et spécialisés et aux travailleurs sociaux pour leur permettre de prodiguer des soins neurologiques fondés sur des bases factuelles, culturellement adaptés et centrés sur les droits humains, y compris en combattant la stigmatisation et la discrimination, au bénéfice de tous et tout au long de la vie ;
- à développer les perspectives de carrière du personnel de neurologie, en renforçant la formation postuniversitaire et en travaillant en partenariat avec les sociétés médicales pour améliorer l'attractivité du secteur de la santé du cerveau ;
- à élargir les programmes d'enseignement existants et à offrir une formation continue sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles neurologiques ;
- à étendre les fonctions du personnel de neurologie à l'encadrement et à l'accompagnement des agents de santé généralistes qui assurent des interventions de neurologie ;
- à tirer parti du potentiel des agents de santé communautaires et à renforcer la collaboration avec les autres prestataires de soins informels, tels que les guérisseurs traditionnels, par une formation, un accompagnement et une supervision efficaces ; et
- à veiller à ce que les personnes atteintes de troubles neurologiques participent à la planification, à la mise au point et à la conduite des formations, selon qu'il conviendra.



68. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

(c) Apporter un soutien aux agents de santé et aux travailleurs sociaux pour la mise en place et la généralisation des services utilisant les technologies de l'information et de la communication, tels que la télémédecine, l'Internet et la téléphonie mobile en vue d'étendre les soins neurologiques aux zones reculées et faiblement dotées en ressources et d'appuyer les services à domicile.

69. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Apporter aux États Membres des outils adaptés pour intégrer les besoins en soins neurologiques dans la planification systématique pour les agents de santé, en se fondant sur le suivi et la collecte des meilleures données disponibles et en suivant une approche fondée sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Lors de la planification, il sera essentiel de recenser les lacunes dans les services, de déterminer la formation et les compétences de base dont les agents de santé et les travailleurs sociaux ont besoin sur le terrain ainsi que les besoins en formation en soins neurologiques avancés.

(b) Fournir un appui aux États Membres dans le renforcement des capacités du personnel de santé et d'aide sociale, y compris les prestataires de soins informels, en s'attachant à promouvoir, à renforcer et à élaborer des orientations et des outils et en appliquant des modèles de formation centrés sur les compétences pour le diagnostic, le traitement et la prise en charge des troubles neurologiques.

70. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Faciliter les échanges d'informations sur les meilleures pratiques et la diffusion des résultats en rapport avec le perfectionnement et la formation des agents de santé en vue de soutenir les efforts nationaux en faveur de la prévention et de la prise en charge des troubles neurologiques.

(b) Appuyer la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités, notamment par la formation théorique et pratique, pour les agents de santé généraux et spécialisés, afin de leur permettre d'identifier les troubles neurologiques et de réaliser des interventions reposant sur des données probantes de sorte à promouvoir le diagnostic, le traitement et la prise en charge des troubles neurologiques.

(c) Aider les autorités nationales à mettre en place des infrastructures de soins de santé et des capacités institutionnelles adéquates pour la formation du personnel de santé en vue de renforcer les systèmes de santé et de développer l'offre de services de qualité.

2.4 Soutien aux aidants

- 71. Les troubles neurologiques ont de profondes conséquences sur les personnes, leur famille et les collectivités. Ces troubles étant de nature chronique, ils nécessitent souvent des soins continus, prodigués en grande partie par des aidants informels.
- 72. Les aidants peuvent être définis par leur relation avec la personne atteinte d'une affection neurologique comme par les soins qu'ils prodiguent. De nombreux aidants sont des parents, mais des amis proches ou des bénévoles peuvent également assumer de telles responsabilités. Les aidants apportent des soins et un soutien d'ordre pratique aux personnes atteintes de troubles neurologiques et jouent un rôle important dans l'organisation des soins prodigués tout au long de la vie.
- 73. Les aidants sont confrontés au stress, aux contraintes liées à leurs fonctions, à des charges financières, à l'isolement social, et au deuil en cas de perte d'êtres chers. Leur rôle et les difficultés qu'ils rencontrent peuvent varier en fonction de leur âge et selon qu'ils s'occupent d'enfants, d'adolescents ou de personnes âgées.
- 74. Prendre soin d'une personne atteinte de troubles neurologiques peut avoir une incidence sur la santé, le bien-être et les relations sociales de l'aidant. Le Plan mondial d'action de santé publique contre la démence présente les principales mesures de soutien aux aidants qui sont également pertinentes pour les autres affections neurologiques.

75. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

- (a) Mettre au point des mécanismes pour associer les personnes atteintes de troubles neurologiques et leurs aidants à la planification des soins, à l'élaboration des politiques et à l'examen juridique et supprimer les obstacles afin de favoriser leur participation, tout en tenant compte des souhaits et des préférences des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs familles.
- (b) Fournir des informations accessibles et fondées sur des données probantes sur les ressources disponibles dans la communauté, telles que les programmes de formation, les soins de relève, les services de santé mentale et d'autres ressources adaptées aux besoins des aidants de personnes atteintes de troubles neurologiques.
- (c) Dans le cadre des soins neurologiques communautaires, offrir des programmes de formation, en collaboration avec des parties prenantes compétentes, au personnel de santé et aux travailleurs sociaux afin de repérer et de réduire les problèmes de stress chez les aidants.
- (d) Élaborer ou renforcer les mécanismes visant à protéger les aidants, y compris par la mise en place de prestations sociales et financières (par exemple, pension, congé ou aménagement des horaires de travail) et de politiques et législations destinées à réduire la stigmatisation et la discrimination et à apporter aux aidants un soutien allant au-delà de leur rôle de prise en charge.



76. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Épauler les États Membres dans l'élaboration et l'évaluation d'informations fondées sur des preuves, de données, de programmes de formation et de services de relève pour les aidants de personnes atteintes de troubles neurologiques, au moyen d'une approche intersectorielle qui soit conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

(b) Faciliter l'accès à des ressources abordables et reposant sur des données factuelles qui permettent aux aidants de personnes atteintes de troubles neurologiques d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences concernant ces troubles, de réduire leur stress émotionnel et d'améliorer leur capacité à faire face aux situations, ainsi que leur efficacité personnelle et leur santé, notamment en utilisant des ressources telles que le Programme mhGAP de l'OMS, le programme iSupport, le programme mDementia,³ le programme de formation qualifiante pour les personnes chargées des soins aux enfants atteints de troubles ou de retards du développement et d'autres mesures en faveur de l'éducation, du développement des compétences et du soutien social.

77. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Mieux faire connaître les conséquences liées au fait de s'occuper de personnes atteintes de troubles neurologiques, notamment la nécessité de protéger les aidants de la discrimination, de les aider à poursuivre les soins tout au long de l'évolution de la maladie et de les encourager à défendre leur propre cause.

(b) Soutenir la mise en œuvre de programmes de formation des aidants et des familles qui soient centrés sur la personne et adaptés au contexte et à la culture pour favoriser leur bien-être et pour améliorer leurs connaissances et compétences tout au long de l'évolution des troubles neurologiques, en partant des ressources existantes comme le programme iSupport et le Programme mhGAP de l'OMS.

³ Be Healthy Be Mobile. A handbook on how to implement mDementia. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021.





Objectif stratégique 3 :

Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention

78. La promotion de la santé du cerveau et la prévention des troubles neurologiques supposent d'agir sur les facteurs de risque modifiables tout en renforçant les facteurs de protection, particulièrement aux étapes critiques du développement cérébral.
79. La promotion du développement optimal du cerveau tout au long de la vie commence dès la période préconceptionnelle et la grossesse, se poursuit à l'enfance et l'adolescence, et entretient des rapports avec le vieillissement en bonne santé. Elle suppose d'encourager un comportement favorable à la santé, une nutrition adéquate, la lutte contre les maladies infectieuses, la prévention des traumatismes crâniens et rachidiens et la réduction de l'exposition à la violence et aux polluants présents dans l'environnement.
80. La CSU représente une dimension clé pour promouvoir la santé et le bien-être du cerveau. Il est important à cet égard de s'attaquer aux déterminants sociaux et économiques par une action intersectorielle coordonnée qui tienne compte des enjeux liés au genre. Une collaboration avec les populations locales, y compris les peuples autochtones, devrait être nouée pour étudier des moyens culturellement appropriés et respectueux des coutumes et des valeurs locales de prévenir les troubles neurologiques.
81. Une approche « Une seule santé »¹ devrait être appliquée aux troubles neurologiques en vue de concevoir et de mettre en œuvre des programmes, des politiques, des lois et des travaux de recherche fondés sur des échanges entre de multiples secteurs et associant la santé publique, la santé animale et végétale et l'environnement, ce qui contribuera à la prévention de ces troubles et, par conséquent, à de meilleurs résultats sanitaires.

1 « Une seule santé ». Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017 (<https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/one-health>, consulté le 1^{er} décembre 2021).



Cibles mondiales pour l'objectif stratégique 3

Cible mondiale 3.1

D'ici à 2031, **80 % des pays** auront au moins un programme intersectoriel opérationnel de promotion de la santé du cerveau et de prévention des troubles neurologiques tout au long de la vie.

Cible mondiale 3.2

Atteinte des cibles mondiales se rapportant à la prévention des troubles neurologiques, telles que définies dans les textes suivants :

- Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles ;
- Vaincre la méningite à l'horizon 2030 : une feuille de route mondiale ; et
- Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables.

3.1 Promotion des comportements sains tout au long de la vie

82. Promouvoir la santé du cerveau tout au long de la vie suppose de mettre l'accent sur les comportements sains. Il existe des liens réciproques forts entre plusieurs troubles neurologiques, tels que la démence et les accidents vasculaires cérébraux, et des MNT comme l'hypertension, le diabète, l'obésité et d'autres troubles connexes, ainsi qu'avec des facteurs de risque comportementaux tels que l'inactivité physique, une alimentation déséquilibrée, le tabagisme et l'usage nocif de l'alcool.

83. La compréhension des facteurs de risque qui contribuent au fardeau des maladies neurologiques peut éclairer les mesures préventives et améliorer les stratégies élaborées pour modifier le cours de la maladie.

84. Le tabagisme est un facteur de risque comportemental associé à des troubles neurologiques tels que l'accident vasculaire cérébral, la démence et la sclérose en plaques. On estime que le tabagisme passif était responsable de 4 % du fardeau des accidents vasculaires cérébraux en 2010.²

85. L'usage nocif de l'alcool, par exemple sa consommation massive, peut avoir un effet direct sur le système nerveux et entraîner des troubles neurologiques tels que la dégénérescence cérébelleuse, les neuropathies, les myopathies, le delirium tremens et une carence en thiamine pouvant conduire à une encéphalopathie de Wernicke ou à un syndrome de Korsakoff. Il contribue également aux accidents de la route, à la violence, aux chutes et aux

² Prüss-Üstün A, Wolf J, Corvalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Organisation mondiale de la Santé, 2016.



lésions du cerveau et de la moelle épinière qu'ils peuvent occasionner.

86. Une bonne hygiène du sommeil est nécessaire pour la santé et le bien-être général des enfants et des adultes. Un sommeil irrégulier peut être un facteur de risque pour certains troubles neurologiques et les personnes atteintes de troubles neurologiques voient souvent leur sommeil perturbé.³

87. La modification des facteurs de risque comportementaux peut renforcer la capacité à faire des choix plus favorables

à la santé et à suivre des modèles de comportement sains qui favorisent une bonne santé du cerveau et réduisent le fardeau des troubles neurologiques. Par exemple, chez les personnes atteintes de troubles neurologiques chroniques tels que la maladie de Parkinson, l'exercice et une activité physique régulière sont associés à des bénéfices sociaux et mentaux et sur la santé du cerveau ainsi qu'à une meilleure qualité de vie, à un meilleur fonctionnement et à une réduction du fardeau supporté par les aidants.

88. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Soutenir les interventions qui ont démontré leur capacité à réduire le risque de troubles neurologiques tout au long de la vie, en mettant en œuvre des stratégies en faveur de comportements sains, notamment en s'attachant à promouvoir le sevrage tabagique, l'arrêt de toute consommation excessive d'alcool, la vaccination et une plus grande activité physique, conformément au Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles, à la Stratégie mondiale visant à réduire l'usage nocif de l'alcool, aux Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité et aux Lignes directrices de l'OMS sur la réduction des risques de déclin cognitif et de démence. Ces mesures devraient être engagées en collaboration avec les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et les autres parties intéressées.

(b) Élaborer et mettre en œuvre des stratégies assorties de ressources suffisantes, à l'échelle de la population, pour promouvoir une nutrition et une alimentation saines, telles qu'on les retrouve dans le plan d'application exhaustif de l'OMS concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, le Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles et le Programme de développement durable à l'horizon 2030, et en suivre l'application.

(c) Promouvoir un aménagement urbain qui améliore l'accès au sport, à l'éducation, aux transports et à l'activité physique de loisir afin de promouvoir l'activité et de permettre aux gens de se détourner d'un mode de vie sédentaire.

³ Worldwide Project on Sleep and Health. Project Overview. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.

**89. Mesures à prendre
par le Secrétariat**

(a) Fournir un appui technique et renforcer les capacités et moyens d'action mondiaux, régionaux et nationaux pour :

- sensibiliser l'opinion aux liens qui existent entre les troubles neurologiques et d'autres maladies non transmissibles ; et
- mettre en œuvre des stratégies pour la réduction et la maîtrise des facteurs de risque modifiables des troubles neurologiques, en élaborant des lignes directrices fondées sur des données probantes proposant des interventions de soins de santé coordonnées et d'un bon rapport coût/efficacité et en mettant en œuvre les lignes directrices pertinentes de l'OMS dans les processus nationaux de planification de la santé et les programmes de développement.

(b) Étoffer, partager et diffuser des données factuelles en vue de soutenir les interventions visant à réduire les facteurs de risque de troubles neurologiques potentiellement modifiables en encourageant les lieux de travail sains, la promotion de la santé dans les écoles et les autres établissements d'enseignement, les initiatives villes-santé, la prise en compte de la dimension sanitaire dans le développement urbain et la protection sociale et environnementale.

**90. Mesures qu'il
est proposé
aux partenaires
internationaux
et nationaux de
prendre**

(a) Promouvoir et généraliser, au niveau de la population, des stratégies pour la santé du cerveau qui couvrent les différentes classes d'âge, tiennent compte des enjeux de genre et se fondent sur l'équité, aux niveaux national, régional et international, afin d'encourager les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et leur famille à adopter des comportements favorables à la santé.

(b) Faciliter l'échange de connaissances et de meilleures pratiques à bases factuelles afin de soutenir les mesures qui ont démontré leur capacité à réduire le risque de troubles neurologiques tout au long de la vie, conformément à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, à la Stratégie mondiale visant à réduire l'usage nocif de l'alcool, à la Stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé et à d'autres stratégies pertinentes.



3.2 Lutte contre les maladies infectieuses

91. Les conséquences neurologiques de maladies infectieuses telles que la méningite, l'encéphalite, la neurocysticercose, le paludisme, l'infection à VIH, la toxoplasmose, la poliomyélite, les maladies à entérovirus, la syphilis et la rage contribuent à la morbidité et à la mortalité mondiales, en particulier dans les populations marginalisées les plus vulnérables, et peuvent entraîner des conséquences tout au long de la vie (par exemple, des déficiences visuelles et auditives, des retards de développement ou encore un handicap moteur ou cognitif), lesquelles peuvent nécessiter des soins de suite spécialisés, dont la réadaptation. Pourtant, bon nombre de ces conséquences neurologiques peuvent être évitées grâce aux programmes de vaccination et à la lutte contre les maladies infectieuses.

92. L'émergence d'infections zoonotiques neurotropes a plusieurs causes, notamment l'intensification agricole non durable, ainsi que l'utilisation accrue des espèces sauvages et leur exploitation.⁴

93. Si des progrès ont été accomplis contre les maladies infectieuses à l'échelle mondiale, les infections épidémiques, notamment celles liées au virus Zika et au SARS-CoV-2, ont mis en lumière l'importance de ces efforts dans la prévention des troubles neurologiques. Ainsi, on estime que la pandémie de COVID-19 devrait avoir une incidence sur la santé du cerveau tout au long de la vie, les stades aigu et post aigu de la maladie étant accompagnés de manifestations neurologiques très variées.

94. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Mettre en œuvre des programmes de prise en charge, d'éradication, d'élimination et de maîtrise des maladies infectieuses et des programmes de vaccination reposant sur les orientations de l'OMS, par exemple la Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030, les lignes directrices sur la prise en charge de la neurocysticercose à *Taenia solium* et la Feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030. Intégrer des méthodes de lutte contre d'autres maladies neuro-infectieuses courantes et accessibles au traitement (comme les encéphalites) ainsi que leurs traitements dans les secteurs de la santé et de l'agriculture, conformément aux orientations de l'OMS sur la prévention des maladies au moyen d'environnements sains.⁵

⁴ Programme des Nations Unies pour l'environnement et International Livestock Research Institute. Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission. Nairobi, Kenya, 2017.

⁵ Prüss-Üstün A, Wolf J, Corvalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

94. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

(b) Soutenir et promouvoir la disponibilité de produits de diagnostic rapides et abordables pour les infections du système nerveux (par exemple, ponction lombaire, microscopie, neuroimagerie).

(c) Collaborer avec l'ensemble des parties prenantes et des secteurs intéressés en vue d'atténuer les risques de maladies infectieuses émergentes à l'origine de troubles neurologiques. Une coordination étroite et des mesures intersectorielles au sein du secteur de la santé et au-delà (par exemple lutte antivectorielle, eau et assainissement, santé animale, hygiène de l'environnement et éducation) seront nécessaires pour optimiser les synergies.

(d) Créer des plans opérationnels nationaux pour mettre en œuvre des interventions contre les maladies neurologiques conformément à l'approche « Une seule santé » en élaborant un plan coordonné qui précise les responsabilités des parties prenantes pour les mesures appliquées à l'être humain, au monde animal, à l'alimentation et aux écosystèmes, et en traitant les animaux pour prévenir la transmission des agents pathogènes neuro-infectieux, par exemple par des vaccinations de masse des chiens afin de prévenir la rage.

(e) Promouvoir les campagnes de vaccination et partager les connaissances sur l'utilité des vaccinations comme méthode de réduction des handicaps neurologiques.

95. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Fournir un appui technique, des outils et des orientations aux États Membres afin de sensibiliser à la lutte contre les maladies infectieuses à l'échelle mondiale, régionale et nationale et de réduire le risque d'infections zoonotiques et de résistance aux antimicrobiens et aux insecticides, notamment en mettant en place des politiques relatives au commerce et à l'élevage du bétail ou des autres animaux.

(b) Mettre en évidence les conséquences neurologiques de la pandémie de COVID-19 et donner des orientations sur la façon de les gérer afin de renforcer la riposte des pays et d'améliorer la prestation de services à tous les niveaux du système de santé.

96. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Promouvoir la collaboration multipartite du secteur de la santé et au-delà, en adoptant une approche « Une seule santé », conformément au Programme 2030 et aux ODD.



3.3 Prévention des traumatismes crâniens/rachidiens et des handicaps associés

- 97.** Les traumatismes cérébraux et les lésions de la moelle épinière requièrent des soins médicaux complexes et onéreux. En 2016, l'incidence mondiale des traumatismes cérébraux était de 27 millions et celle des lésions de la moelle épinière, proche d'un million.⁶ Les traumatismes dus aux accidents de la circulation et les chutes constituent le plus grand nombre de nouveaux cas de traumatismes cérébraux. D'autres causes telles que la maltraitance des enfants, la violence conjugale et les blessures liées à la pratique sportive sont également évitables.
- 98.** Chaque année, 37 millions de chutes sont suffisamment graves pour nécessiter une consultation médicale. Elles touchent essentiellement les adultes âgés de 60 ans et plus, en particulier si des comorbidités altérant l'ambulation existent, telles que la démence, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.⁷
- 99.** Les principaux facteurs de risque d'accidents de la circulation incluent la vitesse ; la consommation d'alcool ou de drogues ; le non-port du casque ; le défaut d'utilisation de la ceinture de sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants ; une visibilité insuffisante des piétons ; les

distractions ou la fatigue du conducteur ; et une application inadéquate de la législation routière.

- 100.** De nombreux traumatismes liés à la pratique du sport peuvent également provoquer des traumatismes cérébraux et des lésions de la moelle épinière. Un traumatisme crânien léger répétitif est associé à une encéphalopathie traumatique chronique et augmente le risque de démence. La sensibilisation, les lois et les politiques visant à éduquer les professionnels du sport, les parents et les athlètes, et l'application de politiques imposant le port du casque ou de dispositifs de protection sont nécessaires pour prévenir certains traumatismes cérébraux et certaines lésions de la moelle épinière.
- 101.** Malgré le nombre élevé de lésions de la tête et de la moelle épinière dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, il subsiste un manque de services, de capacités et de spécialistes formés en neurochirurgie et en neuroréadaptation, qui sont essentiels pour prévenir l'invalidité à long terme et fournir des soins de suivi aux survivants de traumatismes cérébraux et de lésions de la moelle épinière.

6 Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol.*2019;18(1):56-87. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30415-0.

7 Prüss-Üstün A, Wolf J, Corvalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

**102. Mesures qu'il est
proposé aux États
Membres de prendre**

- (a) Mettre en œuvre les recommandations présentées dans le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation et proposées par la Commission pour la sécurité routière mondiale.⁸ Ces recommandations portent sur la gestion de la sécurité routière, la sécurité des routes et la mobilité, la sécurité des véhicules et des usagers de la route, une meilleure réactivité aux urgences consécutives aux accidents et une réadaptation de plus longue durée pour les victimes.
- (b) Consolider les systèmes d'information pour collecter des données sur les traumatismes cérébraux et les lésions de la moelle épinière afin d'approfondir les connaissances sur l'ampleur du problème et ses conséquences.
- (c) Promouvoir des sports de contact plus sûrs et élaborer et mettre en œuvre des politiques et une éducation obligatoire pour les athlètes, les parents et les entraîneurs afin de les informer sur les risques et les complications neurologiques, comme l'épilepsie, liés aux traumatismes cérébraux et aux lésions de la moelle épinière.
- (d) Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des normes et des interventions efficaces pour rendre plus sûrs les espaces domestiques et collectifs pour les personnes âgées, notamment pour ce qui est du manque d'éclairage, des sols glissants, des tapis mal fixés et de l'absence de barrières de sécurité sur les lits, comme préconisé dans la Stratégie et le Plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé.

**103. Mesures à prendre
par le Secrétariat**

- (a) Rassembler et diffuser les données factuelles et les meilleures pratiques pour prévenir ou réduire les traumatismes cérébraux et les lésions de la moelle épinière, notamment concernant la prévention des accidents de la circulation et des chutes par la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie d'action pour la sécurité routière.
- (b) Fournir des conseils, des pratiques reposant sur des faits scientifiques et un appui technique pour la réadaptation précoce et le soutien aux personnes touchées par les conséquences cognitives ou physiques à long terme de traumatismes cérébraux et de lésions de la moelle épinière, afin de minimiser les impacts physiques et psychologiques et de protéger ces personnes contre la discrimination et la stigmatisation.

⁸ Make Roads Safe: A New Priority for Sustainable Development. Commission for Global Road Safety; 2006.



104. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Promouvoir la collaboration entre plusieurs parties prenantes pour sensibiliser à la sécurisation des réseaux routiers et aux mesures de protection, pour le bien de l'ensemble des usagers de la route, notamment les plus vulnérables (piétons, cyclistes et motocyclistes) afin de prévenir les traumatismes cérébraux et les lésions de la moelle épinière.

(b) Promouvoir le partage des connaissances et faciliter le renforcement aux niveaux mondial, régional, intergouvernemental et national des politiques sur la conduite sans risque et les traumatismes liés à la pratique sportive, et promouvoir les initiatives nationales visant à accroître le port du casque conformément au manuel de l'OMS intitulé « Casques : manuel de sécurité routière à l'intention des décideurs et des praticiens ».

3.4 Réduction des risques environnementaux

105. L'exposition aux risques environnementaux et professionnels peut avoir une influence directe sur la santé du cerveau. Par exemple, en 2019, environ 5 % de la charge mondiale des accidents vasculaires cérébraux, calculée en perte d'années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY), étaient attribuables à la pollution de l'air ambiant.⁹ Partout dans le monde, les communautés vulnérables sont plus exposées aux toxines environnementales en raison des conditions dans lesquelles elles vivent et travaillent.

106. Les encéphalopathies induites par les toxines, notamment l'exposition à des métaux lourds

tels que le plomb,¹⁰ le mercure et les polluants atmosphériques (monoxyde de carbone, etc.), peuvent causer de graves préjudices pour la santé et le système nerveux, dans tous les groupes d'âge.¹¹

107. Une corrélation a été établie entre la maladie de Parkinson et l'exposition professionnelle et non professionnelle aux pesticides.¹² Par ailleurs, les polluants environnementaux, tels que la lumière vive, une qualité d'air inadéquate et le bruit, peuvent déclencher des migraines.¹³

9 Voir GBD Compare.Viz Hub. Institute for Health Metrics and Evaluation; 2021 (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>, consulté le 1er décembre 2021).

10 Élimination des peintures au plomb à l'échelle mondiale : pourquoi et comment les pays devraient agir : note technique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020.

11 Sécurité chimique. Genève, Organisation mondiale de la Santé (https://www.who.int/health-topics/chemical-safety#tab=tab_1, consulté le 1er décembre 2021).

12 Ascherio A, Schwarzschild MA. The epidemiology of Parkinson's disease: risk factors and prevention. *Lancet Neurol.* 2016;15(12):1257-1272. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30230-7; Ascherio A, Chen H, Weisskopf MG, O'Reilly E, McCullough ML, Calle EE, et al. Pesticide exposure and risk for Parkinson's disease. *Ann Neurol.* 2006;60(2):197-203. doi: 10.1002/ana.20904.

13 Prüss-Üstün A, Wolf J, Corvalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

108. Les changements climatiques font partie des nombreux changements touchant l'environnement de manière concomitante à l'échelle mondiale qui influent à la fois sur la santé humaine et sur les affections neurologiques, souvent du fait d'interactions. Par exemple, la transmission vectorielle de virus neurotropes, tels que le virus Zika, le virus de l'encéphalite japonaise et le virus du Nil occidental, dépend aussi bien du climat, des mouvements de la population, du déboisement, des modes d'utilisation des terres, des pertes de diversité biologique, de la topologie des surfaces d'eaux douces que de la densité des populations humaines.¹⁴

109. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Promouvoir les collaborations conjointes entre les ministères intéressés (environnement, santé, eau et assainissement), afin d'associer promotion de la santé du cerveau et prévention des troubles neurologiques au moyen de stratégies axées sur la promotion de conditions de travail et environnementales et d'un mode de vie favorables à la santé, conformément aux orientations de l'OMS sur la prévention des maladies grâce à un environnement sain.¹⁵ En particulier :

- accélérer l'élimination des peintures au plomb au niveau mondial par des mesures réglementaires et juridiques ;
- élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des programmes de promotion et de protection de la santé dans tous les secteurs pour limiter l'exposition aux pesticides et à d'autres substances chimiques prioritaires, comme le trichloréthylène, auxquels des effets neurotoxiques ont été associés ; et
- s'attaquer aux aspects sanitaires de l'exposition au mercure et aux composés du mercure grâce à la collaboration entre les autorités sanitaires, les autorités en matière d'environnement et d'autres intervenants.

(b) En partenariat avec des organisations non gouvernementales, le secteur privé et d'autres parties prenantes intersectorielles, intégrer les déterminants environnementaux spécifiques à la santé du cerveau et aux troubles neurologiques dans des stratégies d'atténuation plus larges visant à réduire l'impact des changements climatiques, notamment des interventions et des politiques qui favorisent l'accès à un air pur (air des habitations et air ambiant), telles que la réduction des combustibles fossiles et la promotion de l'utilisation de fourneaux plus propres, ainsi qu'à une eau potable, à un assainissement et à une hygiène adéquats.

14 Changement climatique et santé. Principaux faits. Genève, Organisation mondiale de la Santé (<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>, consulté le 1^{er} décembre 2021).

15 Prüss-Üstün A, Wolf J, Corvalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.



110. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Aider les États Membres à évaluer et à mettre en œuvre des options fondées sur des données probantes qui répondent à leurs besoins et à leurs capacités, afin d'évaluer l'impact des politiques publiques, de la production de données factuelles et des orientations relatives aux risques environnementaux comme la pollution atmosphérique, les métaux lourds, les pesticides et les solvants industriels sur la santé du cerveau et la prévention des troubles neurologiques.

111. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Défendre, aux niveaux national, régional et international, les orientations de l'OMS sur la prévention des maladies grâce à un environnement sain et souligner l'incidence majeure des changements climatiques sur la santé du cerveau, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030 et à ses objectifs de développement durable.

(b) Collaborer avec les parties prenantes afin de soutenir l'élaboration de normes internationales pour les polluants environnementaux (par exemple, émissions, fumée secondaire et niveaux de toxines environnementales) afin d'orienter la législation.

(c) Appuyer la recherche pour comprendre la contribution des facteurs de risque environnementaux à la morbidité et à la mortalité des troubles neurologiques, en particulier dans les milieux faiblement dotés en ressources.

3.5 Promotion d'un développement optimal du cerveau chez les enfants et les adolescents

112. Les premiers stades de la vie, notamment le stade foetal et la naissance, présentent une occasion particulièrement importante de promouvoir la santé du cerveau et de prévenir les troubles neurologiques qui peuvent avoir des conséquences à vie, le cerveau d'un enfant se développant et s'adaptant rapidement en réponse à l'environnement immédiat, à la nutrition et à la stimulation.

113. L'optimisation du développement cérébral durant les années d'apprentissage suppose de créer les conditions propices à des soins attentifs¹⁶ et à un soutien à la famille et à l'éducation des enfants au moyen de politiques, de programmes et de services publics. Les collectivités et les personnes chargées des soins sont alors en mesure de veiller à la bonne santé des enfants et à une nutrition adéquate tout en les protégeant des dangers.

16 Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir afin de transformer la santé et le potentiel humain. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.

114. Il a également été démontré que l'accès à l'éducation institutionnelle et à l'éducation inclusive pour les enfants ayant un handicap améliore les résultats en matière de santé du cerveau. Tous les enfants et les adolescents doivent pouvoir vivre, étudier et créer des liens sociaux dans des environnements favorables, sains et sûrs, à l'abri de la stigmatisation, de la discrimination ou du harcèlement. L'exposition à des conditions difficiles en début de vie, telles que la maltraitance, le défaut de soins, l'expérience de la guerre ou du conflit, une nutrition maternelle inadaptée (par exemple une carence en acide folique ou en fer), la mauvaise santé d'un aidant, l'usage de substances psychoactives, les infections congénitales (par exemple le syndrome TORCH, la toxoplasmose, la rubéole, le cytomégalovirus ou l'herpès) ou les complications à la naissance, peut avoir des effets délétères sur le cerveau en développement et des conséquences à long terme sur la santé du cerveau.

115. Certains polluants présents dans l'environnement ont un effet connu sur le

neurodéveloppement. C'est notamment le cas de la pollution atmosphérique, des métaux lourds présents dans le sol et l'eau, du plomb dans la peinture à usage domestique, du mercure dans les aliments d'origine marine, des expositions professionnelles et des pesticides.¹⁷ Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à la toxicité du plomb, une exposition, même à des niveaux faibles, pouvant entraîner une baisse de la faculté de concentration, des troubles du comportement et un moindre niveau d'instruction atteint.

116. L'activité physique peut être bénéfique pour la santé des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques. Il est donc recommandé de limiter les comportements sédentaires, tels que les divertissements sur écran (télévision et ordinateur) et les communications numériques, par exemple par téléphone mobile. De plus, une bonne hygiène du sommeil chez les enfants et les adolescents maximise les avantages pour la santé et le développement du cerveau.

117. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Élaborer, financer et mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir un bon développement du cerveau et prévenir les troubles neurologiques chez l'enfant et l'adolescent, en s'attachant particulièrement à l'intervention précoce et à la réadaptation.

(b) Optimiser les soins de santé périnataux et infantiles, y compris le travail et l'accouchement sans risques pour prévenir les lésions cérébrales hypoxo-ischémiques, les soins intensifs néonataux, le recours à des professionnels de l'accouchement, le contact peau à peau (méthode « mère kangourou »), l'allaitement maternel, les soins de santé mentale de la mère, une nutrition adéquate, la vaccination et les interventions relatives au développement de l'enfant pour la prestation de soins adaptés et l'apprentissage précoce conformément au Cadre de soins attentifs de l'OMS.

17 Prüss-Üstün A, Wolf J, Corvalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.



117. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

Encourager et renforcer l'évaluation neurodéveloppementale chez les enfants et les adolescents afin de faciliter un diagnostic et une intervention précoces.

(c) En partenariat avec les autorités nationales de réglementation compétentes et les parties prenantes intéressées, élaborer, renforcer et suivre des politiques et des plans d'action nationaux sur l'allaitement, l'alimentation et la nutrition, conformément à la Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, au plan d'application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, et à l'ensemble des recommandations de l'OMS sur le marketing des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants.¹⁸

(d) Accélérer la pleine mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac afin de réduire l'exposition fœtale, le tabagisme passif de l'enfant et le tabagisme chez l'adolescent.

(e) Élaborer et mettre en œuvre, selon qu'il conviendra, des politiques et programmes nationaux intersectoriels et complets visant à réduire l'usage nocif de l'alcool pendant la grossesse, afin de prévenir les complications telles que les troubles causés par l'alcoolisation fœtale.

(f) Promouvoir l'accès des adolescents aux interventions recommandées dans la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent, y compris dans les situations de crise humanitaire et les environnements fragiles. Apporter un soutien aux interventions visant à promouvoir la santé et le développement du cerveau des adolescents et mettre en place, selon qu'il conviendra, des espaces accueillants pour les adolescents, afin d'apporter une première réponse aux besoins de protection, de bien-être psychosocial et d'éducation non institutionnalisée des adolescents.

(g) Élaborer des politiques assorties de moyens suffisants pour proposer une éducation physique de meilleure qualité dans les établissements d'enseignement, notamment en offrant des occasions de pratiquer une activité physique avant, pendant et après la journée scolaire. Les parcs, zones arborées et espaces verts des centres urbains peuvent améliorer localement la qualité de l'air et offrir aux enfants un refuge adapté au jeu. Mettre en œuvre les lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, notamment les recommandations sur le temps de loisirs devant un écran.

¹⁸ Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children: implementation manual. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017.

117. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre (suite)

(h) Renforcer les mécanismes de surveillance des indicateurs de base pour la santé et le développement du cerveau des enfants et des adolescents, notamment les facteurs de risque et de protection.

118. Mesures à prendre par le Secrétariat

(a) Fournir un appui technique, des outils et des orientations aux États Membres et renforcer les capacités nationales pour promouvoir un développement optimal du cerveau chez l'enfant et l'adolescent à travers :

- une amélioration du pouvoir mobilisateur, au sein des ministères de la santé et d'autres secteurs, pour l'élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de stratégies nationales et/ou infranationales fondées sur des données factuelles et pour la planification intersectorielle des ressources connexes visant à optimiser le développement du cerveau chez l'enfant et l'adolescent ; et
- la compilation et le partage des connaissances et des meilleures pratiques relatives aux politiques existantes qui portent sur le développement au cours de la petite enfance et de l'adolescence, y compris des codes de pratique et des mécanismes permettant d'évaluer la protection des droits humains.

119. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

(a) Faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes en faveur des enfants et des adolescents qui visent à remédier à la maltraitance, au défaut de soins, à la nutrition inadéquate de la mère, aux problèmes de santé des aidants, à l'usage de substances psychoactives (telles que l'alcool et le tabac), aux infections congénitales, aux complications à la naissance et à la présence de polluants dans l'environnement, aux niveaux mondial, régional, national et/ou infranational.



Objectif stratégique 4 :

Favoriser la recherche et l'innovation et renforcer les systèmes d'information

120. Des données issues d'une recherche de qualité doivent être générées pour éclairer les politiques, la planification et l'élaboration de programmes axés sur les troubles neurologiques. Elles jetteront une lumière nouvelle sur les services de santé, les modèles de soins et les traitements efficaces, et favoriseront l'innovation et un accès équitable aux produits comme les technologies médicales liées aux troubles neurologiques, notamment pour la prévention, la réduction des risques, le diagnostic précoce, le traitement, la guérison éventuelle et les soins.

121. La complexité de la recherche sur le cerveau et de la recherche en neurologie nécessite une meilleure coordination de l'environnement de recherche, supposant une participation multipartite, des partenariats public-privé et l'allocation de ressources suffisantes. Dans ce contexte, il est essentiel de cultiver un environnement qui favorise les collaborations en matière

de recherche, y compris le partage des données, afin de réduire les doubles emplois, de cerner les lacunes en matière de connaissances, d'accélérer l'innovation et de renforcer les capacités dans les milieux à faible revenu.

122. Il convient de donner la priorité à la recherche sur la mise en œuvre, notamment à l'évaluation des systèmes de santé, afin d'exploiter et d'étendre les stratégies de prévention et de traitement des troubles neurologiques. Une telle démarche facilitera le suivi des interventions et permettra la reproduction et l'adaptation des interventions couronnées de succès.

123. Une meilleure représentation des pays à revenu faible ou intermédiaire dans l'environnement de la recherche en neurosciences devrait également tenir compte des besoins nationaux et locaux afin que les stratégies de diagnostic et de prise en charge des troubles neurologiques soient adaptées au contexte.



Cibles mondiales pour l'objectif stratégique 4

Cible mondiale 4.1

D'ici à 2031, **80 % des pays** collecteront régulièrement des données sur un ensemble d'indicateurs de base concernant les troubles neurologiques et en rendront compte tous les trois ans a minima, au travers de leurs systèmes nationaux de données et d'information sanitaires.

Cible mondiale 4.2

La production de la recherche mondiale sur les troubles neurologiques sera doublée d'ici à 2031.

124. Afin de mieux soutenir et guider la recherche et le développement de solutions novatrices aux troubles neurologiques, les programmes de recherche doivent intégrer une participation véritable des personnes atteintes de troubles neurologiques, de leur famille et de leurs aidants.

125. La planification efficace d'interventions ciblées et leur mise en place doivent s'appuyer sur des données solides, normalisées et facilement accessibles. Pourtant, les données sur les troubles neurologiques font fortement défaut, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire comme dans les pays à revenu élevé.

4.1 Investissement dans la recherche

126. Pour réduire l'incidence des troubles neurologiques et améliorer la vie des personnes qui en sont atteintes, des investissements soutenus dans la recherche biomédicale, clinique et translationnelle et dans la recherche sur la mise en œuvre sont essentiels afin d'orienter les mesures de prévention, le diagnostic, le traitement et les soins, et de créer des possibilités de guérir davantage de troubles neurologiques.

127. Toutes les activités de recherche et d'innovation liées aux troubles neurologiques doivent être ancrées dans l'équité, la diversité et l'inclusion, et accroître la participation des personnes atteintes de troubles neurologiques.

128. Les investissements dans la recherche neurologique devraient s'accompagner d'une collaboration accrue entre les États Membres et les parties concernées, et veiller particulièrement au renforcement de la coopération mondiale et régionale. La mise en avant d'un programme de recherche mondial en neurologie augmentera la probabilité d'obtenir des progrès réels dans la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, tout en réduisant les doubles emplois et la redondance des axes de recherche et des coûts.



129. Afin de stimuler la recherche et le développement en neurologie, il faut une action concertée visant à créer des infrastructures de recherche, renforcer les ressources humaines en recherche-développement et intensifier la collaboration entre la communauté des chercheurs, les professionnels de la santé, les personnes atteintes de troubles neurologiques et le secteur privé, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

130. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

- (a)** Accroître les investissements dans la recherche et améliorer la gouvernance de cette activité en tant qu'élément constitutif de l'action nationale contre le fardeau des troubles neurologiques. Faciliter la mise au point de nouveaux produits de diagnostic, traitements, technologies et innovations pour les personnes atteintes de troubles neurologiques ou présentant un risque d'en développer. Ces innovations recouvrent notamment l'utilisation des mégadonnées, l'intelligence artificielle, les produits de diagnostic, la médecine de précision, les outils de suivi et d'évaluation des maladies, les technologies d'assistance, les produits pharmaceutiques et les nouveaux modèles de soins.
- (b)** Soutenir la collaboration nationale, régionale et internationale en matière de recherche sur les troubles neurologiques afin de produire de nouvelles connaissances sur la promotion, la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins de ces troubles, et traduire en actions les faits observés dans ce domaine médical. Encourager le partage des données de recherche et le libre accès à ces informations.
- (c)** Renforcer les connaissances et les capacités des décideurs sur le besoin d'innovation dans le domaine de la santé du cerveau et souligner l'importance de financer en priorité la recherche sur les troubles neurologiques dans les instituts nationaux de recherche.
- (d)** Renforcer les capacités institutionnelles nationales en matière de recherche et d'innovation, par exemple pour la mise au point de nouveaux médicaments pour le traitement des troubles neurologiques, notamment pour les enfants, en améliorant les infrastructures, les équipements et les fournitures de recherche.
- (e)** Impliquer et soutenir les personnes atteintes de troubles neurologiques, leurs aidants et les organisations qui les représentent afin qu'elles participent activement au processus de recherche, de la planification à la mise en œuvre.

**131. Mesures à prendre
par le Secrétariat**

(a) Soutenir les appels à une augmentation des investissements dans la recherche sur les troubles neurologiques, à travers l'établissement des priorités en matière de recherche et la définition des thèmes à traiter dans les domaines de la recherche biomédicale, clinique et translationnelle et de la recherche sur la mise en œuvre aux niveaux mondial, régional et national.

(b) Mobiliser les centres collaborateurs de l'OMS, les établissements universitaires, les organisations et les alliances qui s'intéressent à la recherche, en vue de renforcer les moyens de recherche sur les troubles neurologiques.

(c) Soutenir les mécanismes de coordination internationale pour faciliter l'harmonisation des efforts de recherche mondiaux en neurologie et favoriser une communication et un échange d'information réguliers entre les intervenants afin de bâtir une communauté des chercheurs connectée à l'échelle mondiale.

(d) Offrir des conseils et un appui technique aux États Membres pour la mise au point de nouveaux produits de diagnostic et traitements et de technologies innovantes en lien avec les troubles neurologiques, et de mécanismes visant à en garantir l'équité d'accès et de déploiement, en particulier dans les milieux faiblement dotés en ressources.

**132. Mesures qu'il
est proposé
aux partenaires
internationaux
et nationaux de
prendre**

(a) Promouvoir la recherche sur les troubles neurologiques et obtenir le soutien financier nécessaire, participer à des activités de définition des priorités et contribuer à la diffusion des résultats des travaux de recherche dans une langue simple auprès des décideurs, du public et des personnes atteintes de troubles neurologiques ainsi que de leur famille et de leurs aidants.

(b) Inviter la communauté de la recherche, les professionnels de la santé, les décideurs et le secteur privé à promouvoir l'innovation et le développement de nouveaux outils et traitements liés aux troubles neurologiques, tout en garantissant un accès équitable et abordable à ces produits dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

(c) Apporter un soutien à l'action menée au niveau national pour renforcer les capacités en matière de recherche-développement, d'innovation et de partage des connaissances, notamment par le renforcement des capacités institutionnelles, les collaborations entre chercheurs et la création de bourses de recherche et d'études sur la prévention, le diagnostic, le traitement et la prise en charge des troubles neurologiques.



132. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre (suite)

(d) Soutenir la recherche sur la mise en œuvre dans les pays à revenu faible ou intermédiaire afin de générer des connaissances sur les obstacles à l'intégration du traitement des troubles neurologiques dans les soins cliniques généralisés et sur les stratégies efficaces pour surmonter ces obstacles.

4.2 Systèmes de données et d'information

133. La disponibilité des données sur les soins de santé et la protection sociale relatives aux troubles neurologiques peut aider à cerner les lacunes en matière de prestation de services, améliorer l'accessibilité et la coordination des soins pour les personnes atteintes de troubles neurologiques et promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure détection des changements et des tendances à l'échelle de la population.

134. Les systèmes d'information sur les troubles neurologiques sont souvent rudimentaires ou absents, en particulier dans les pays à faible revenu, ce qui rend difficile l'acquisition de données sur la disponibilité

et l'utilisation des services neurologiques et sur les besoins des personnes atteintes de troubles neurologiques et de leurs aidants.

135. L'intégration systématique de données de routine, en population, dans les systèmes d'information sanitaire, et le suivi régulier des troubles neurologiques au regard d'un ensemble d'indicateurs de base, sont deux préalables essentiels à la définition de mesures fondées sur des éléments scientifiques visant à améliorer les services et à mesurer les progrès de l'application des programmes nationaux se rapportant aux troubles neurologiques et à la santé du cerveau.

136. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Intégrer le suivi des troubles neurologiques dans les systèmes d'information sanitaire courants et à tous les niveaux de soins, afin de définir, compiler et communiquer systématiquement des données de base ventilées par sexe, par âge et selon d'autres indicateurs d'équité afin d'améliorer la prestation des services neurologiques et les stratégies de promotion et de prévention, et de mieux connaître les déterminants sociaux des troubles neurologiques.

(b) Encourager l'utilisation de registres de patients, les programmes de surveillance, l'analyse et la publication de données sur la disponibilité, l'évaluation de l'utilisation et la couverture des services et des traitements efficaces relatifs aux troubles neurologiques.

(c) Appuyer la collecte de données et les renvois à d'autres mécanismes de suivi et de responsabilisation afin d'éviter les doubles emplois au niveau des pays.

**137. Mesures à prendre
par le Secrétariat**

(a) Apporter un appui technique aux États Membres afin qu'ils :

- élaborent des systèmes nationaux de collecte des données ou les améliorent, afin de renforcer la collecte de données sur les troubles neurologiques ;
- renforcent les capacités et les ressources nationales pour la collecte et l'analyse systématiques des données relatives aux troubles neurologiques, et pour une exploitation facilitée de ces informations ;
- élaborent un ensemble d'indicateurs de base et de cibles conformes au présent plan d'action, à d'autres plans d'action mondiaux et aux cadres de suivi de l'OMS afin de suivre les résultats relatifs aux troubles neurologiques.

**138. Mesures qu'il
est proposé
aux partenaires
internationaux
et nationaux de
prendre**

(a) Aider les États Membres à mettre en place des systèmes de surveillance et d'information et des registres dans lesquels sont consignés les indicateurs de base et l'évaluation des résultats des traitements de troubles neurologiques pour les patients.

(b) Encourager et faciliter la participation des personnes atteintes de troubles neurologiques, de leur famille et leurs aidants à la collecte, à l'analyse et à l'exploitation des données sur les troubles neurologiques.

(c) Soutenir la création d'espaces d'échange et de dialogue entre les pays sur les meilleures pratiques en matière de collecte, de gestion et d'utilisation des données.



Objectif stratégique 5 :

Renforcer l'approche de santé publique à l'égard de l'épilepsie

139. L'épilepsie touche des personnes de tous âges, sexes, races et niveaux de revenu. Les populations pauvres et celles qui vivent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire supportent une charge disproportionnée, ce qui constitue une menace pour la santé publique et le développement économique et social.

140. Dans de nombreuses régions du monde, les personnes atteintes d'épilepsie et leur famille souffrent de stigmatisation et de discrimination en raison de l'ignorance, des idées fausses et des attitudes négatives entourant la maladie. L'éducation, l'emploi, le mariage et la reproduction sont autant de domaines souvent sources de multiples difficultés pour elles.

141. Le risque de décès prématuré chez ces personnes est trois fois supérieur à celui observé dans la population générale. Parmi les causes les plus importantes, citons la mort subite inattendue en épilepsie, l'état de mal épileptique, les brûlures, la noyade et le suicide. La surmortalité est plus élevée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et est associée à un manque d'accès aux établissements de santé, à d'importantes lacunes en matière de traitement et à l'incapacité d'agir sur les causes potentiellement évitables de l'épilepsie.

142. L'épilepsie coexiste souvent avec d'autres problèmes de santé qui peuvent l'aggraver, y compris d'autres troubles neurologiques, ce qui nécessite une approche synergique pour traiter les affections concomitantes.



Cibles mondiales pour l'objectif stratégique 5

Cible mondiale 5.1

D'ici à 2031, les pays auront augmenté la couverture des services liés à l'épilepsie de 50 % par rapport à la couverture en 2021.

Cible mondiale 5.2

D'ici à 2031, **80 % des pays** auront élaboré ou mis à jour leur législation en vue de promouvoir et de protéger les droits humains des personnes atteintes d'épilepsie.

5.1 Accès aux services de prise en charge de l'épilepsie

143. L'épilepsie se traite très bien et plus de 70 % des personnes qui en sont atteintes pourraient vivre sans convulsions si elles avaient accès à un traitement antiépileptique adapté, notamment à ceux qui présentent le meilleur rapport coût/efficacité et qui figurent dans la Liste modèle OMS des médicaments essentiels. Malgré cela, les lacunes de la couverture thérapeutique sont estimées à 75 % dans les pays à revenu faible et sont nettement plus élevées dans les zones rurales que dans les zones urbaines.¹

144. Les importantes lacunes de la couverture thérapeutique peuvent être dues à la fois à une capacité amoindrie des systèmes de santé, à une répartition inéquitable des ressources et au faible niveau de priorité accordé aux soins antiépileptiques. Parmi

les facteurs qui aggravent ces lacunes, citons le manque de personnel, l'accès limité aux médicaments antiépileptiques, le manque de connaissances et d'assurance des personnels en soins de santé primaires en matière de prise en charge des cas d'épilepsie, les perceptions erronées et la stigmatisation.

145. Par leur approche centrée sur la personne, les soins de santé primaires permettent de répondre aux besoins de santé des personnes atteintes d'épilepsie. S'il existe une volonté politique et en combinant différentes stratégies innovantes, la prévention, le diagnostic et le traitement de l'épilepsie peuvent être intégrés dans les services de santé primaires à moindre coût, même dans les milieux à faibles ressources.

¹ Epilepsy: a public health imperative. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019.



146. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Élaborer des modèles de soins pour l'épilepsie qui fomentent la promotion de soins primaires de haute qualité centrés sur la personne en tant que pierre angulaire des services de santé intégrés tout au long de la vie, et renforcer dans ce sens ceux qui existent. Des systèmes d'orientation solides et fonctionnels avec des services spécialisés ainsi que des soins pour l'épilepsie rebelle devraient être mis à disposition. Les spécialistes soutiennent l'intégration des soins de l'épilepsie dans les soins de santé primaires, par exemple la confirmation du diagnostic de l'épilepsie, la prise en charge de l'épilepsie rebelle et l'évaluation du recours justifié à une chirurgie résectrice.

(b) Améliorer la formation et le soutien en matière de diagnostic de l'épilepsie et de gestion des personnels de soins de santé primaires, notamment des agents de santé en établissement, de proximité et communautaires, du personnel scolaire et des personnels de soin en situation d'urgence, ainsi que la formation spécialisée aux niveaux secondaire et tertiaire.

(c) Élaborer des stratégies de mobilisation significative des communautés afin d'augmenter la demande de services en lien avec l'épilepsie.

(d) Mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la disponibilité des médicaments antiépileptiques et leur accessibilité, notamment financière, en tenant compte également des besoins spécifiques des enfants, des adolescents et des femmes en âge de procréer.

Les options stratégiques ci-après peuvent être envisagées :

- inclure les médicaments antiépileptiques essentiels dans les listes et formulaires nationaux de médicaments essentiels ;
- renforcer les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de sélection ;
- accroître l'approvisionnement et la distribution ; et
- améliorer l'accès aux médicaments soumis à un contrôle, comme le phénobarbital.

(e) Améliorer les soins afin de prévenir les causes courantes de l'épilepsie telles que les lésions périnatales, notamment les lésions cérébrales hypoxo-ischémiques, les infections du système nerveux central, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes cérébraux en favorisant des grossesses et des naissances sans risque, en prévenant les traumatismes crâniens et en maîtrisant les maladies neuroinfectieuses telles que la neurocysticercose, la méningite, l'encéphalite et le paludisme, conformément à d'autres initiatives mondiales.

- (f) Fournir aux personnes atteintes d'épilepsie de l'information sur leur trouble pour les aider à comprendre l'importance et les avantages de l'observance du traitement et les sensibiliser aux déclencheurs de crises, à la surveillance et aux stratégies fondamentales d'autogestion et d'autoprise en charge (par exemple par un sommeil adéquat et des repas réguliers).
- (g) Renforcer le suivi et l'évaluation des services liés à l'épilepsie au moyen de systèmes d'information sanitaire qui fonctionnent bien, génèrent des données fiables et aident les acteurs locaux, nationaux et mondiaux à exploiter les informations ainsi fournies pour prendre de meilleures décisions et enrichir leurs connaissances. Les données devraient être recueillies auprès de sources multiples, dont les registres et les systèmes de déclaration de maladies, les enquêtes et les ensembles de données administratives et cliniques.

147. Mesures à prendre par le Secrétariat

- (a) Élaborer et diffuser des orientations techniques pour combler les principales lacunes et renforcer les mesures prises face à l'épilepsie aux niveaux mondial et national en tenant compte des principales considérations en matière de politiques, de mise en œuvre et de recherche.
- (b) Donner des orientations sur le renforcement de la mise en œuvre du volet « épilepsie » du Programme d'action OMS Comblant les lacunes en santé mentale (mhGAP), dont des recommandations actualisées, afin que des soins de qualité soient dispensés et des interventions fondées sur des données probantes soient menées dans le cadre des soins de santé primaires, avec l'appui des technologies numériques.
- (c) Offrir un soutien aux États Membres pour la collecte et le partage des meilleures pratiques en matière de prestation de services fondés sur des données probantes et de coordination des soins dans la prise en charge de l'épilepsie.

148. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre

- (a) Mettre en place des équipes communautaires pour soutenir les personnes atteintes d'épilepsie, leur famille et leurs aidants au sein de la collectivité et renforcer les mécanismes de dialogue avec les praticiens de médecine complémentaire et alternative tels que les guérisseurs.
- (b) Plaider en faveur de la disponibilité de médicaments antiépileptiques à des prix abordables à tous les niveaux du système de soins de santé, en particulier dans les centres de soins primaires.



148. Mesures qu'il est proposé aux partenaires internationaux et nationaux de prendre (suite)

(c) Aider les personnes atteintes d'épilepsie, leur famille et leurs aidants à accéder aux services, par exemple en mettant en place des outils d'information et de formation faciles à utiliser et fondés sur des données factuelles concernant l'épilepsie et les services y afférents, et/ou en créant des sites Web présentant des informations et des conseils au niveau local.

d) Mener des travaux de recherche sur la mise en œuvre, notamment la diffusion des enseignements à retenir, afin d'accélérer la mise à l'échelle des stratégies efficaces pour renforcer les services liés à l'épilepsie.

5.2 Mobilisation des personnes atteintes d'épilepsie et soutien en leur faveur

149. Les personnes atteintes d'épilepsie et leur famille, quel que soit le niveau de ressources du milieu dans lequel elles vivent, sont confrontées à la stigmatisation et à la discrimination en raison des conceptions erronées et des attitudes négatives qui entourent la maladie, y compris les croyances selon lesquelles une personne atteinte serait possédée par des esprits malins ou la maladie serait contagieuse.

150. La stigmatisation se traduit par des violations des droits humains et l'exclusion sociale. Dans certains endroits, il peut être interdit aux enfants atteints d'épilepsie de fréquenter l'école, et pour les adultes atteints, il peut être difficile de trouver un emploi adapté ou de se marier.

151. Il faut des stratégies novatrices pour renforcer les efforts internationaux et la prise d'initiatives au niveau national visant à appuyer les politiques et les lois en faveur des personnes atteintes d'épilepsie, améliorer les attitudes du public et réduire la stigmatisation dont ces personnes font l'objet tout en respectant pleinement leurs droits humains.

152. Les personnes atteintes d'épilepsie, leurs aidants et les organisations qui les représentent doivent disposer des moyens d'agir et être associés au plaidoyer, aux politiques, à la planification, à la législation, à la prestation de services, au suivi et à la recherche en rapport avec l'épilepsie.

153. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre

(a) Encourager l'inclusion des points de vue et des besoins des personnes atteintes d'épilepsie et de leur famille dans les politiques de santé pertinentes et dans tous les aspects de la mise en place et du renforcement des services qui soutiennent leur autonomie. Une grande attention doit être accordée à l'égalité des sexes, à la diversité et à l'équité pour renforcer les moyens d'action des plus vulnérables.

(b) Mettre au point une législation qui mette en avant et protège les droits des personnes atteintes d'épilepsie et interdise toute discrimination à leur égard dans des domaines tels que

**153. Mesures qu'il est
proposé aux États
Membres de prendre
(suite)**

l'éducation, l'emploi, le mariage et la planification familiale, l'obtention d'un permis de conduire et les loisirs, ou renforcer dans ce sens les textes de loi existants. Améliorer la responsabilisation en mettant en place des mécanismes et en utilisant les organismes indépendants existants dans la mesure du possible, pour suivre et évaluer la mise en œuvre des politiques et de la législation relatives à l'épilepsie afin de veiller au respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

(c) Faciliter les initiatives communautaires conjointes dans lesquelles les prestataires communautaires jouent un rôle moteur et la société civile participe activement, dans le cadre de la mise à l'échelle des initiatives maîtrisées par la communauté concernant l'épilepsie.

(d) Améliorer l'accès à toute une gamme de services centrés sur la personne, adaptés aux spécificités culturelles et réactifs, notamment en œuvrant en lien avec des organisations non gouvernementales locales et d'autres parties prenantes pour fournir aux personnes atteintes d'épilepsie les informations nécessaires afin qu'elles fassent des choix avisés et prennent des décisions éclairées concernant leur prise en charge.

**154. Mesures à prendre
par le Secrétariat**

(a) Soutenir la participation active des personnes atteintes d'épilepsie et de leur famille à l'élaboration de produits techniques, normes et standards qui les concernent.

(b) Aider les États Membres à développer les capacités de base pour s'engager efficacement dans des processus participatifs associant les personnes atteintes d'épilepsie et leur famille et pour tirer parti des résultats obtenus au moment de prendre des décisions.

**155. Mesures qu'il
est proposé
aux partenaires
internationaux
et nationaux de
prendre**

(a) Veiller à ce que les personnes atteintes d'épilepsie prennent pleinement part aux activités de la collectivité et accroître leur autonomie afin de favoriser leur participation à la vie culturelle, sociale et civique.

(b) Soutenir les activités de plaidoyer et d'éducation du public liées à l'épilepsie à l'intention des agents de santé communautaires, des responsables locaux, des personnes atteintes d'épilepsie et de leur famille afin de corriger les idées fausses, de contrer les attitudes négatives envers les personnes atteintes d'épilepsie et d'informer sur les gestes à accomplir pour aider une personne prise d'une crise convulsive.



5.3 L'épilepsie comme point d'entrée d'autres troubles neurologiques

- 156.** L'épilepsie peut résulter de causes génétiques ou d'autres causes souvent inconnues, mais peut également être une conséquence d'autres affections neurologiques. Par exemple, l'épilepsie peut être consécutive à un AVC, à une infection, à une tumeur cérébrale ou à un traumatisme cérébral. L'épilepsie peut également coexister avec d'autres affections neurologiques. Par exemple, la migraine survient chez environ 19 % des personnes atteintes d'épilepsie et une déficience intellectuelle touche environ 26 % des adultes et entre 30 et 40 % des enfants atteints d'épilepsie.²
- 157.** Une crise convulsive peut également être le symptôme d'autres affections telles qu'une infection, un déséquilibre métabolique, une tumeur cérébrale ou une maladie neurodégénérative. Elle peut également signaler une détérioration ou une évolution d'une affection neurologique sous-jacente.
- 158.** De nombreux troubles neurologiques, dont l'épilepsie, partagent des technologies de diagnostic et de thérapie similaires, et des approches semblables en matière de recherche, de pharmacologie et d'aide psychosociale.
- 159.** Un service de prise en charge de l'épilepsie efficace peut représenter une bonne occasion de renforcer la prise en charge d'autres troubles neurologiques. Ainsi, l'épilepsie peut servir de point d'entrée pour accélérer le renforcement des services et du soutien en lien avec l'ensemble de ces types d'affection. D'autres troubles neurologiques, déterminés au regard des priorités nationales, devraient être considérés parallèlement au traitement et aux soins de l'épilepsie afin d'obtenir les meilleurs résultats pour tous. Cette approche peut être applicable dans certaines parties du monde, tandis que dans d'autres cas, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et les troubles neurodégénératifs, ou encore les maux de tête (migraine, etc.) peuvent servir de point d'entrée.
- 160. Mesures qu'il est proposé aux États Membres de prendre**
- (a)** Orienter les systèmes de santé afin d'étendre la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins existants de l'épilepsie à la prise en charge des comorbidités en tant qu'élément essentiel à tous les niveaux de soins. Par exemple, des soins de qualité liés à l'épilepsie dispensés par des équipes interdisciplinaires peuvent être appliqués à d'autres troubles neurologiques.
 - (b)** Renforcer la capacité des agents de soins de santé primaires à développer des compétences qui vont au-delà des soins de l'épilepsie pour couvrir d'autres troubles neurologiques, y compris le traitement des comorbidités, en s'appuyant sur le programme d'action OMS Comblant les lacunes en santé mentale.³

² Epilepsy: a public health imperative. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019.

³ Programme d'action Comblant les lacunes en santé mentale (mhGAP). Genève, Organisation mondiale de la santé (<https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/treatment-care/mental-health-gap-action-programme>, consulté le 1er décembre 2021).

**160. Mesures qu'il est
proposé aux États
Membres de prendre
(suite)**

- (c)** Tirer parti des produits de diagnostic de l'épilepsie tels que l'électroencéphalogramme (EEG), les technologies de neuro-imagerie (y compris la tomographie par ordinateur et l'IRM) et les services d'aiguillage spécialisés (dont la chirurgie) pour inclure des installations de diagnostic et de prise en charge d'autres troubles neurologiques.
- (d)** Élargir les systèmes d'approvisionnement développés pour les médicaments antiépileptiques afin d'améliorer l'accès à des médicaments efficaces et de qualité pour d'autres troubles neurologiques.

**161. Mesures à prendre
par le Secrétariat**

- (a)** Aider les États Membres à intégrer les soins d'autres affections neurologiques dans les services dispensés d'ordinaire pour l'épilepsie au niveau des soins primaires en fournissant des stratégies, des processus et des outils que les pays appliqueront pour renforcer les capacités des personnels de santé.
- (b)** Promouvoir et faciliter l'échange de meilleures pratiques aux échelons international, régional et national pour guider la mise en œuvre de modèles de soins intégrés pour l'épilepsie et d'autres troubles neurologiques.

**162. Mesures qu'il
est proposé
aux partenaires
internationaux
et nationaux de
prendre**

- (a)** Activer les réseaux nationaux et faire pression sur les administrateurs, les responsables de l'élaboration des politiques et d'autres intervenants pour qu'ils intègrent les soins pour les comorbidités (c'est-à-dire les problèmes de santé physique et mentale) comme faisant partie intégrante des services de traitement et de prise en charge de l'épilepsie.



Annexe 1 :

Résolutions et engagements mondiaux présentant un intérêt par rapport aux troubles neurologiques

Systèmes de santé

1. Déclaration politique de l'ONU sur la couverture sanitaire universelle (2019)
2. Déclaration d'Astana sur les soins de santé primaires (2018)
3. Résolution WHA67.22 « Accès aux médicaments essentiels » (2014)
4. Résolution WHA67.19 « Renforcement des soins palliatifs en tant qu'élément des soins complets à toutes les étapes de la vie » (2014)
5. Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l'horizon 2030 (2016)
6. Résolution WHA71.8 « Amélioration de l'accès aux technologies d'assistance » (2018)
7. Résolution WHA60.29 « Technologies sanitaires » (2007)
8. Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030
9. Résolution WHA72.16 « Systèmes de soins d'urgence en vue de la réalisation de la couverture sanitaire universelle : assurer des soins rapides pour les personnes gravement malades ou blessées » (2019)

Résolutions et engagements mondiaux présentant un intérêt par rapport aux troubles neurologiques (suite)

Santé mentale, affections neurologiques et liées à l'usage de substances psychoactives	10. Stratégie mondiale visant à réduire l'usage nocif de l'alcool (2010) 11. Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2030 12. Résolution WHA67.8 « Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre autistique » (2014) 13. Résolution WHA68.20 « Charge mondiale de l'épilepsie » (2015) 14. Plan mondial d'action de santé publique contre la démence 2017-2025 (2017) 15. Décision EB146(14) « Intensifier l'action pour réduire l'usage nocif de l'alcool » (2020) 16. Résolution WHA73.10 « Action mondiale contre l'épilepsie et les autres troubles neurologiques » (2020) 17. Décision EB148(3) « Promouvoir la préparation et l'action en matière de santé mentale dans le cadre des situations d'urgence de santé publique » (2021)
Maladies non transmissibles	18. Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2030 19. Projet de Plan d'action mondial de l'OMS relatif au handicap 2014-2021 20. Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (2018) 21. Rehabilitation 2030: a call for action initiative
Maladies infectieuses	22. Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015 23. Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH 2016-2021 : vers l'élimination du sida (2016) 24. Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 25. Décision EB146(6) « Méningite : prévention et lutte » (2020)
Maladies tropicales négligées	26. Décision EB146(9) « Maladies tropicales négligées » (2020) 27. Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre les objectifs de développement durable : feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030 28. Zero by 30: The Global Strategic Plan to end human deaths from dog-mediated rabies by 2030

Résolutions et engagements mondiaux présentant un intérêt par rapport aux troubles neurologiques (suite)

Santé de la famille et de l'enfant	29. Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030) 30. INSPIRE : Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants (2016) 31. Action mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents (AA-HAI). Orientations à l'appui de la mise en œuvre dans les pays (2017) 32. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential (2018)
Vieillesse et santé	33. Stratégie et plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé (2016-2020) 34. Décennie pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030)
Environnement et changements climatiques	35. Changement climatique et santé humaine : risques et mesures à prendre (2003) 36. Amélioration de la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets (2010) 37. Convention de Minamata sur le mercure (2014) 38. Résolution WHA67.11 « Conséquences pour la santé publique de l'exposition au mercure et aux composés du mercure : le rôle de l'OMS et des ministères de la santé publique dans la mise en œuvre de la Convention de Minamata » (2014) 39. Résolution WHA69.4 « Rôle du secteur de la santé dans l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dans la perspective de l'objectif fixé pour 2020 et au-delà » (2016) 40. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks (2018) 41. WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and wellbeing sustainably through healthy environments (2019)
Déterminants sociaux de la santé	42. Résolution EB148.R2 « Déterminants sociaux de la santé » (2021)
Droits humains	43. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 44. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 45. Convention relative aux droits de l'enfant (1989) 46. Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)

Liens:

1. <https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf>.
2. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328129/WHO-HIS-SDS-2018.61-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
3. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-fr.pdf.
4. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R19-fr.pdf.
5. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327511/B144_26-fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
6. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71-REC1/A71_2018_REC1-fr.pdf#page=41.
7. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/F/reso-60-fr.pdf#page=67.
8. <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>.
9. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R16-fr.pdf.
10. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44485/9789242599930_fre.pdf?sequence=1.
11. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
12. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-fr.pdf#page=37.
13. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_2015_REC1-fr.pdf#23page=111.
14. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_28-fr.pdf.
15. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146-REC1/B146_REC1-fr.pdf#page=63.
16. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73-REC1/A73_REC1-fr.pdf#page=58.
17. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148-REC1/B148_REC1-fr.pdf#page=36.
18. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236>.
19. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/254650>.
20. <https://digitallibrary.un.org/record/1648984?ln=fr>.
21. <https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030>.
22. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/170881>.
23. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250576/WHO-HIV-2016.05-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
24. <https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241564991>.
25. [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146\(6\)-fr.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146(6)-fr.pdf).
26. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146-REC1/B146_REC1-fr.pdf#page=61.
27. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332420>.
28. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/328053>.
29. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/276425>.
30. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/child-maltreatment/inspire-infographic-fr.pdf?sfvrsn=cc61d642_2.
31. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272405/WHO-FWC-MCA-17.05-fre.pdf?ua=1>.
32. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
33. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/252947>.
34. <https://www.who.int/fr/initiatives/decade-of-healthy-ageing>.
35. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42951>.
36. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/3961>.
37. <https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/2021-06/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-FR.pdf>.
38. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-fr.pdf#page=44.
39. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC1/A69_2016_REC1-fr.pdf#page=36.
40. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196>.
41. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331959>.
42. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_R2-fr.pdf.
43. <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
44. <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>.
45. <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
46. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf>.

Annexe 2 :

Indicateurs pour mesurer les progrès accomplis par rapport aux cibles définies dans le Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031

1. Les indicateurs permettant d'évaluer les progrès accomplis par rapport aux cibles définies dans le Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031 constituent un sous-ensemble des informations et notifications dont les États Membres ont besoin pour pouvoir surveiller de manière adéquate leurs politiques et programmes relatifs aux troubles neurologiques. Compte tenu du caractère mondial et facultatif des cibles, les États Membres ne sont pas nécessairement tenus de toutes les atteindre, mais ils peuvent contribuer individuellement, dans une plus ou moins grande mesure, à ce qu'elles soient atteintes collectivement.
2. Les cibles générales définies pour chaque objectif stratégique constituent une base de référence pour mesurer l'action collective et les progrès des États Membres par rapport aux objectifs mondiaux et elles ne doivent pas empêcher de fixer des cibles plus ambitieuses au niveau national, en particulier pour les pays qui ont déjà atteint les cibles mondiales.
3. Comme indiqué sous l'objectif stratégique 4 du plan, le Secrétariat fournira, sur demande, des orientations, une formation et une assistance technique aux États Membres afin qu'ils mettent en place des systèmes nationaux d'information permettant de recueillir des données sur les indicateurs relatifs aux apports, aux activités et aux résultats du système dans le domaine de la neurologie. Il s'agit de continuer à s'appuyer sur les informations existantes plutôt que de créer des systèmes nouveaux ou parallèles. Les mécanismes existants de suivi et de responsabilisation dans les domaines de la santé mentale, des maladies non transmissibles et des maladies infectieuses seront utilisés pour mesurer les cibles et indicateurs pertinents du Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031.
4. L'expression « troubles neurologiques » sert à désigner des atteintes des systèmes nerveux central et périphérique, dont l'épilepsie, les céphalées, les maladies neurodégénératives, les maladies cérébrovasculaires, les troubles neuro-infectieux/neuro-immunologiques, les affections neuromusculaires, les troubles du développement neurologique, les traumatismes cérébraux et les lésions de la moelle épinière (« moelle spinale », selon la nouvelle nomenclature) et les cancers du système nerveux. Les troubles neurologiques responsables des plus grands handicaps dans le monde sont les accidents vasculaires cérébraux, la migraine, la démence, la méningite et l'épilepsie.
5. L'épilepsie peut servir de point d'entrée pour renforcer plus vite les services, y compris les systèmes d'information sur d'autres troubles neurologiques.

Tableau 1. Liste des cibles mondiales

1	1.1 D'ici à 2031, 75 % des pays auront adapté ou mis à jour les politiques, stratégies, plans ou cadres nationaux existants pour y inclure les troubles neurologiques.
	1.2 D'ici à 2031, 100 % des pays auront au moins une campagne ou un programme opérationnel de sensibilisation aux troubles neurologiques.
2	2.1 D'ici à 2031, 75 % des pays auront intégré les troubles neurologiques dans les prestations incluses dans la CSU.
	2.2 D'ici à 2031, 80 % des pays fourniront, dans le cadre des soins primaires, les médicaments essentiels et les technologies de base nécessaires à la prise en charge des troubles neurologiques.
3	3.1 D'ici à 2031, 80 % des pays auront au moins un programme intersectoriel opérationnel de promotion de la santé du cerveau et de prévention des troubles neurologiques tout au long de la vie.
	3.2 Atteinte des cibles mondiales se rapportant à la prévention des troubles neurologiques, telles que définies dans les textes suivants : • Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; • Vaincre la méningite à l'horizon 2030 : une feuille de route mondiale ; et • Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables.
4	4.1 D'ici à 2031, 80 % des pays collecteront régulièrement des données sur un ensemble d'indicateurs de base concernant les troubles neurologiques et en rendront compte tous les trois ans a minima, grâce à leurs systèmes nationaux de données et d'information sanitaires.
	4.2 La production de la recherche mondiale sur les troubles neurologiques sera doublée d'ici à 2031.
5	5.1 D'ici à 2031, les pays auront augmenté la couverture des services liés à l'épilepsie de 50 % par rapport à la couverture en 2021.
	5.2 D'ici à 2031, 80 % des pays auront élaboré ou mis à jour leur législation en vue de promouvoir et de protéger les droits humains des personnes atteintes d'épilepsie.



Objectif stratégique 1 :

Améliorer la hiérarchisation et renforcer la gouvernance

Cible mondiale 1.1	D'ici à 2031, 75 % des pays auront adapté ou mis à jour les politiques, stratégies, plans ou cadres nationaux existants pour y inclure les troubles neurologiques.
Indicateur 1.1	Existence d'une politique, d'une stratégie, d'un plan ou d'un cadre national opérationnel qui a été adapté ou mis à jour pour aborder ou intégrer les troubles neurologiques.
Moyens de vérification	Existence et disponibilité matérielle d'une politique, d'une stratégie, d'un plan ou d'un cadre fourni par l'autorité nationale et confirmé lors de l'examen.
Observations/ hypothèses/raison d'être	Disponibilité d'un ensemble écrit et organisé de principes, d'objectifs ou de mesures visant à réduire la charge attribuable aux troubles neurologiques dans une population, réunis dans un document autonome traitant spécifiquement des troubles neurologiques ou intégrés à des plans de santé ou autres. Des stratégies ou des plans nationaux fondés sur des priorités liées au contexte peuvent également être élaborés pour certains troubles neurologiques, tels que l'épilepsie ou la démence. Une fois encore, il peut s'agir de plans autonomes, ou bien certains troubles neurologiques peuvent être inclus dans le plan général de santé et/ou dans le plan national de santé mentale. Ces plans sont considérés comme valables s'ils ont été approuvés/publicés par le Ministère de la santé (ou équivalent) ou par le parlement. Pour les pays ayant un système fédéral, l'indicateur fera référence aux politiques ou plans de la plupart des États ou des provinces du pays. Les politiques ou les plans relatifs aux troubles neurologiques peuvent être isolés ou intégrés dans d'autres politiques ou plans généraux concernant la santé ou le handicap, par exemple les maladies non transmissibles, les maladies infectieuses, la santé mentale, la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, le vieillissement, le handicap.

Objectif stratégique 1 : Améliorer la hiérarchisation et renforcer la gouvernance (suite)

Cible mondiale 1.2	D'ici à 2031, 100 % des pays auront au moins une campagne ou un programme opérationnel de sensibilisation aux troubles neurologiques.
Indicateur 1.2	Existence d'au moins une campagne ou un programme opérationnel de sensibilisation aux troubles neurologiques.
Moyens de vérification	Inventaire des campagnes de sensibilisation ou de plaidoyer sur les troubles neurologiques actuellement mises en œuvre et en cours, décrit projet par projet et fourni par l'autorité nationale.
Observations/ hypothèses/raison d'être	Existence d'une campagne nationale de sensibilisation du public pour mieux faire comprendre et faire reculer la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes atteintes de troubles neurologiques au cours de l'année écoulée. Les campagnes de sensibilisation peuvent, et dans l'idéal devraient, englober tant des stratégies universelles s'adressant à l'ensemble de la population (par exemple des campagnes médiatiques contre la stigmatisation et la discrimination) que des stratégies visant les groupes vulnérables recensés localement (par exemple, les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique, les enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de handicaps physiques et intellectuels, les personnes touchées par des situations d'urgence et les minorités ethniques). Elles devraient de préférence aborder des questions transversales, notamment la prévention et la promotion de la santé. Alors que les campagnes peuvent être conçues pour couvrir plusieurs troubles neurologiques, les pays privilégient parfois certains troubles neurologiques en particulier, comme l'épilepsie. Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer devraient avoir pour objectif de favoriser une compréhension précise des troubles neurologiques, de faire reculer la stigmatisation et la discrimination associées aux troubles neurologiques, d'expliquer ce que sont les droits humains des personnes atteintes de troubles neurologiques et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et d'améliorer la capacité de la population générale à reconnaître les premiers symptômes et signes des troubles neurologiques. Le terme « opérationnel » signifie que les éléments suivants sont présents : ressources financières exclusives, administration du programme, preuves documentées des progrès et de l'impact.



Objectif stratégique 2 :

Fournir un diagnostic, un traitement et des soins efficaces et adaptés, en temps opportun

Cible mondiale 2.1	D'ici à 2031, 75 % des pays auront intégré les troubles neurologiques dans les prestations incluses dans la CSU.
Indicateur 2.1	Dans le cadre de l'ensemble des prestations incluses dans la couverture sanitaire universelle, existence d'un ensemble de services de santé et d'appui fondés sur des données probantes, prioritaires, essentiels et de qualité pour les troubles neurologiques
Moyens de vérification	Couverture sanitaire universelle avérée – ensemble de prestations prioritaires sur la base des informations fournies par l'autorité nationale et confirmées lors de l'examen.
Observations/hypothèses/raison d'être	L'ensemble des prestations prioritaires dans le cadre de la CSU correspond à des interventions, des services et des programmes de santé prioritaires fondés sur des données probantes, y compris des mesures intersectorielles et des politiques fiscales, définis dans le cadre d'un processus délibératif qui tient compte des réalités économiques et des préférences sociales. Il définit explicitement quels programmes, services et interventions devraient être fournis et couverts financièrement pour la population. Parmi les services et l'appui proposés pour les troubles neurologiques figurent une protection contre les risques financiers et les services de promotion de la santé, les soins préventifs, le traitement, les soins de réadaptation et les soins palliatifs tout au long de la vie. L'ensemble de prestations prioritaires devrait comporter des services de qualité optimisée, efficaces, efficients, accessibles, centrés sur le patient, équitables et sûrs, en s'appuyant sur des modalités de financement justes et durables. Les interventions doivent être réalisées par des prestataires qualifiés capables de fournir rapidement des services standard au niveau approprié d'un système de santé réglementé et cibler des groupes précis. Cet indicateur vise à fournir des données démontrant que l'ensemble de prestations prioritaires contient des éléments relatifs aux troubles neurologiques. Les troubles neurologiques prioritaires tels que l'épilepsie peuvent être spécifiquement repérés.

Objectif stratégique 2 : Fournir un diagnostic, un traitement et des soins efficaces et adaptés, en temps opportun (suite)

Cible mondiale 2.2	D'ici à 2031, 80 % des pays fourniront, dans le cadre des soins primaires, les médicaments essentiels et les technologies de base nécessaires à la prise en charge des troubles neurologiques.
Indicateur 2.2	Les pays signalent que les médicaments essentiels et les technologies de base nécessaires à la prise en charge des troubles neurologiques sont disponibles.
Moyens de vérification	Proportion de pays qui déclarent disposer durablement d'un ensemble de médicaments essentiels et de technologies de base pertinents pour les troubles neurologiques abordables dans les établissements de soins primaires.
Observations/ hypothèses/raison d'être	Les médicaments essentiels et les technologies de base ont pour but d'être disponibles dans le contexte d'un système de santé opérationnel à tout moment en quantité suffisante, sous la forme pharmaceutique appropriée, avec une assurance de qualité et à un prix accessible pour les individus et la communauté. Les listes de médicaments essentiels et de technologies de base servent aussi de guide pour les achats et l'approvisionnement dans le secteur public. Pour cet indicateur, il est prévu de fournir un panier contenant précisément les médicaments essentiels et les technologies de base utilisés pour la prise en charge des troubles neurologiques. Le panier proposé correspond à une approche équilibrée permettant de suivre les médicaments traceurs pertinents et les technologies de base pour les troubles neurologiques, et de collecter et d'analyser les données de façon pratique. Le contenu du panier est censé être indicatif de l'accès aux médicaments et aux technologies de base pour les troubles neurologiques, mais ne constitue pas une liste complète ou exhaustive. Les médicaments antiépileptiques sont un exemple de médicaments traceurs. Une partie importante de la charge de l'épilepsie dans les pays à revenu faible ou intermédiaire peut être évitée en améliorant la disponibilité systématique des médicaments antiépileptiques.



Objectif stratégique 3 :

Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention

Cible mondiale 3.1	D'ici à 2031, 80 % des pays auront au moins un programme intersectoriel opérationnel de promotion de la santé du cerveau et de prévention des troubles neurologiques tout au long de la vie.
Indicateur 3.1	Existence d'au moins un programme intersectoriel opérationnel de promotion de la santé du cerveau et de prévention des troubles neurologiques tout au long de la vie.
Moyens de vérification	Inventaire du programme de sensibilisation à la santé du cerveau et de prévention des troubles neurologiques/atténuation des risques actuellement mis en œuvre et opérationnel, décrit projet par projet et fourni par l'autorité nationale.
Observations/ hypothèses/raison d'être	De nombreuses affections neurologiques sont évitables, y compris 25 % des cas d'épilepsie à l'échelle mondiale. L'existence d'un programme intersectoriel de promotion de la santé du cerveau et de prévention des troubles neurologiques ou d'atténuation des risques au cours de l'année écoulée doit être signalée. Alors que les programmes peuvent être conçus pour couvrir plusieurs troubles neurologiques, les pays privilégient parfois certains troubles neurologiques en particulier, comme l'épilepsie. Les programmes devraient être nationaux et comporter de préférence à la fois des stratégies de sensibilisation de la population de portée universelle (par exemple, des campagnes dans les médias), portant sur toutes les étapes de la vie, et des stratégies visant les groupes vulnérables recensés localement (par exemple, les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique, les enfants, les personnes âgées, les personnes exposées à la violence domestique et fondée sur le genre, les personnes ayant un faible niveau scolaire et les minorités ethniques). Le terme « opérationnel » signifie que les éléments suivants sont présents : ressources financières exclusives, administration du programme, preuves documentées des progrès et de l'impact.

Objectif stratégique 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention (suite)

Cible mondiale 3.2

Atteinte des cibles mondiales se rapportant à la prévention des troubles neurologiques, telles que définies dans les textes suivants :

- Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles ;¹
- Vaincre la méningite à l'horizon 2030 : une feuille de route mondiale ;² et
- Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables.³

Indicateur 3.2

Indicateurs pertinents tels que définis dans :

Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles :

- Réduction relative de 10 % de la prévalence de l'activité physique insuffisante.
- Baisse relative d'au moins 10 % de l'usage nocif de l'alcool, selon qu'il convient dans le contexte national.
- Arrêt de l'augmentation du diabète et de l'obésité.
- Baisse relative de 25 % de la prévalence de l'hypertension artérielle ou limitation de la prévalence de l'hypertension artérielle selon la situation nationale.
- Réduction relative de 30 % de la prévalence du tabagisme actuel chez les personnes de 15 ans et plus.

1 Organisation mondiale de la Santé et al., Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 (2013) (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_7-fr.pdf).

2 Organisation mondiale de la Santé, Vaincre la méningite d'ici 2030 : une feuille de route mondiale (projet du 26 octobre 2020), 2020.

3 Organisation mondiale de la Santé, Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables, 2014.

Objectif stratégique 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention (suite)

Indicateur 3.2 (suite)

Vaincre la méningite à l'horizon 2030 : une feuille de route mondiale :

- Maintien ou obtention dans tous les pays de la couverture pour les vaccins contre *Neisseria meningitidis* (Nm), *Streptococcus pneumoniae* (Spn) et *Haemophilus influenzae* de type B (Hib), conformément au calendrier vaccinal.
- Actualisation ou élaboration de politiques mondiales sur les vaccins contre Nm, Spn, Hib et le streptocoque du groupe B à mesure que de nouveaux vaccins et de nouvelles données probantes sont disponibles.
- Un programme de formation sur l'identification, le diagnostic, l'orientation et le traitement de la méningite, y compris des séquelles potentielles, a été créé et intégré dans la formation existante dans plus de 80 % des pays.
- Des lignes directrices fondées sur des données probantes et des outils recommandés sur le traitement et la prise en charge de la méningite bactérienne ont été élaborés et mis en œuvre dans 80 % des pays.
- Les services communautaires pour les personnes souffrant de handicaps de longue durée dus à la méningite ont été intégrés dans les initiatives existantes d'inclusion du handicap dans plus de 50 % des pays.

Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables :

- 95 % des femmes accoucheront en présence de personnel qualifié, et chaque mère et son nouveau-né bénéficieront de soins efficaces, de grande qualité et respectueux.
- Au moins 75 % des enfants qui ne respirent pas spontanément à la naissance après avoir été bien séchés et stimulés seront réanimés au moyen d'une ventilation par ballon et masque ; au moins 75 % des prématurés dont l'état est stable ou des nouveau-nés pesant moins de 2000 grammes recevront des soins de type « mère kangourou » ainsi que d'autres soins appropriés ; et au moins 75 % des nourrissons susceptibles de souffrir d'une infection bactérienne grave recevront un traitement antibiotique.
- 90 % des femmes et des nouveau-nés bénéficieront de soins postnatals de grande qualité dans les deux jours suivant la naissance.

Objectif stratégique 3 : Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention (suite)

Moyens de vérification	Rapports présentés aux organes directeurs de l'OMS conformément au Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2030 et aux documents Vaincre la méningite à l'horizon 2030 : une feuille de route mondiale et Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables.
Observations/ hypothèses/raison d'être	Série de définitions des indicateurs pertinents figurant dans : • Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2030 ; • Vaincre la méningite à l'horizon 2030 : une feuille de route mondiale ; • Chaque nouveau-né : Plan d'action pour mettre fin aux décès évitables.



Objectif stratégique 4 :

Favoriser la recherche et l'innovation et renforcer les systèmes d'information

Cible mondiale 4.1	D'ici à 2031, 80 % des pays collecteront régulièrement des données sur un ensemble d'indicateurs de base concernant les troubles neurologiques et en rendront compte tous les trois ans a minima, grâce à leurs systèmes nationaux de données et d'information sanitaires.
Indicateur 4.1	Les pays disposent de systèmes de données et d'information sanitaires qui fonctionnent pour recueillir régulièrement des données sur un ensemble d'indicateurs de base concernant les troubles neurologiques et en rendre compte.
Moyens de vérification	Registre de patients, données agrégées ou dossiers médicaux provenant de diverses sources au niveau du système (national, infranational ou local). Réponses fournies par l'autorité nationale.
Observations/ hypothèses/raison d'être	Le suivi et l'évaluation systématiques des données sanitaires permettent d'obtenir des éléments factuels pour l'élaboration de politiques et la prestation des services, améliorent l'accessibilité et la coordination des soins pour les personnes atteintes de troubles neurologiques et conduisent à une meilleure compréhension et à une meilleure détection des changements et des tendances à l'échelle de la population. Les indicateurs de base des troubles neurologiques comprennent ceux ayant trait aux cibles définies dans le présent plan d'action, ainsi que d'autres indicateurs essentiels des actions menées dans le cadre du système de santé et des systèmes sociaux (par exemple formation et capacités en ressources humaines, et disponibilité et utilisation des services). Les données doivent porter sur des troubles neurologiques spécifiques considérés comme prioritaires par le pays pour l'élaboration des politiques et la prestation de services. Les données doivent être ventilées par sexe et par groupe d'âge ainsi que par trouble neurologique (épilepsie, par exemple). On peut aussi, si nécessaire, recourir à des enquêtes pour compléter les données obtenues grâce aux systèmes d'information courants. Les données seront collectées, analysées et communiquées par l'OMS dans le cadre de son Atlas de la neurologie.

Objectif stratégique 4 : Favoriser la recherche et l'innovation et renforcer les systèmes d'information (suite)

Cible mondiale 4.2	La production de la recherche mondiale sur les troubles neurologiques sera doublée d'ici à 2031.
Indicateur 4.2	Nombre d'articles de recherche publiés sur les troubles neurologiques (articles de recherche publiés dans une revue indexée à comité de lecture). L'indicateur mesure la production de travaux de recherche en neurologie suivant les études nationales publiées.
Méthode de vérification	Recherches documentaires menées de façon centralisée tous les trois ans, stratifiées par pays d'origine, par sujet et par type de recherche, à l'aide de données bibliométriques pour la dernière année civile.
Observations/ hypothèses/raison d'être	L'indicateur mesure la production de travaux de recherche en neurologie suivant les études nationales publiées. Le nombre d'articles de recherche publiés chaque année dans des revues à comité de lecture et indexés est indicatif de la quantité (et de la qualité) de la recherche sur les troubles neurologiques menée dans un pays. Il permet d'évaluer indirectement l'engagement d'un pays en faveur de la recherche sur les troubles neurologiques, ce qui aura en fin de compte un impact sur les résultats pour les personnes atteintes de troubles neurologiques. Dans la mesure du possible, les résultats de la recherche seront stratifiés pour différents troubles neurologiques tels que l'épilepsie ou la maladie de Parkinson.

**Objectif stratégique 5 :****Renforcer l'approche de santé publique à l'égard de l'épilepsie**

Cible mondiale 5.1	D'ici à 2031, les pays auront augmenté la couverture des services liés à l'épilepsie de 50 % par rapport à la couverture en 2021.
Indicateur 5.1	Proportion de personnes atteintes d'épilepsie qui ont utilisé les services au cours des 12 derniers mois (%).
Méthode d'estimation/calcul	Couverture des services calculée en fonction du nombre de personnes qui bénéficient de services donnés par rapport à la population qui a besoin de l'intervention. $\frac{\text{Couverture des services} = \text{Nombre de personnes bénéficiant de services}}{\text{Nombre de personnes atteintes d'épilepsie}} \times 100 \%$ Numérateur : nombre de personnes atteintes d'épilepsie bénéficiant de services, déterminé à l'aide des systèmes d'information courants ou d'une enquête initiale et de suivi auprès des établissements de santé dans une ou plusieurs zones géographiques définies d'un pays. Dénominateur : nombre total de personnes atteintes d'épilepsie dans l'échantillon de population, déterminé à l'aide d'enquêtes nationales ou, à défaut, d'estimations de la prévalence au niveau infrarégional.
Observations/hypothèses/raison d'être	Les estimations de la couverture des services doivent être établies pour tous les troubles neurologiques, mais elles sont limitées ici à l'épilepsie comme indicateur de référence afin de rendre possible le travail statistique. L'éventail des établissements de santé s'étend des centres de soins primaires aux hôpitaux généraux et spécialisés ; ces différents établissements peuvent offrir une prise en charge et un soutien sociaux ainsi qu'un traitement psychosocial et/ou pharmacologique en ambulatoire ou dans le cadre d'une hospitalisation. Pour limiter le travail statistique, et lorsque c'est nécessaire, les pays peuvent effectuer l'enquête uniquement auprès des établissements hospitaliers et de ceux où les patients passent la nuit (en sachant que l'estimation sera moins précise si les soins primaires et les autres dispensateurs de services ne sont pas pris en compte).

Objectif stratégique 5 : Renforcer l'approche de santé publique à l'égard de l'épilepsie (suite)

Observations/ hypothèses/ raison d'être (suite)	Les pays peuvent choisir de mesurer la couverture effective en effectuant une enquête auprès des ménages et en adoptant une approche en cascade pour fournir des informations sur le pourcentage de personnes atteintes d'épilepsie qui ont bénéficié d'un diagnostic ; le pourcentage de personnes atteintes d'épilepsie qui ont accès à des médicaments antiépileptiques appropriés, abordables et sûrs ; et le pourcentage de personnes traitées qui ont réussi à maîtriser suffisamment leurs crises.
Cible mondiale 5.2	D'ici à 2031, 80 % des pays auront élaboré ou mis à jour leur législation en vue de promouvoir et de protéger les droits humains des personnes atteintes d'épilepsie.
Indicateur 5.2	Existence de législations nationales relatives à l'épilepsie conformes aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains.
Méthode d'estimation/ vérification	Existence matérielle de législations relatives à l'épilepsie et confirmation qu'elles sont conformes aux normes internationales et régionales en matière de droits humains.
Observations/ hypothèses/ raison d'être	Confirmation que les législations disponibles sont conformes aux normes internationales et régionales en matière de droits humains, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la conduite automobile, du mariage et de la fécondité, en vue de lutter contre la discrimination à l'égard des personnes atteintes d'épilepsie. Pour les pays ayant un système fédéral, l'indicateur fera référence aux lois ou plans de la plupart des États ou des provinces du pays. Les lois peuvent être isolées ou intégrées dans la législation concernant la santé en général ou le handicap. Les normes en matière de droits humains seront fondées sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et comprendront des dispositions relatives à l'éducation, à l'emploi, à la conduite automobile, au mariage et à la fécondité.

Pour plus d'information, contactez:

Unité Santé Cérébrale

Département Santé Mentale, Santé Cérébrale et Toxicomanie

Organisation mondiale de la Santé

Avenue Appia 20
CH-1211 Genève 27
Switzerland

Email: brainhealth@who.int

Website: <https://www.who.int/health-topics/brain-health>

